

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar

AÑO XI - NOVIEMBRE 1988

18

DROGADICCION

Editora invitada:

Lic. María Rosa Glasserman

INTRODUCCION	7
Lic. María Rosa Glasserman.	
INTRODUCCION	11
Dr. W. Ricardo Grimson.	
DROGADICCION Y FAMILIA	17
Dra. Silvie Angel, Dr. Pedro Angel.	
COMENTARIO AL ARTICULO "DROGADICCION Y FAMILIA"	
DE S. ANGEL Y P. ANGEL	22
Dr. C.M. Díaz Usandivaras.	
ENTREVISTA REALIZADA EN EL CENTRO DE TERAPIA FAMILIAR	
MONCEAU A SILVIE ANGEL	25
Lic. María Rosa Glasserman.	
CICLO DE VIDA Y ABANDONO. El vacío espiritual de la adicción	
a la heroína	33
Ph.D. Sandra B. Coleman, A.C.S.W. J. Doreene Kaplan, Ph.D. Robert	
W. Downing.	
COMENTARIO AL ARTICULO "CICLO DE VIDA Y	
ABANDONO" DE S.B. COLEMAN, J.D. KAPLAN Y R.W. DOWNING	56
Dr. Juan Carlos Nocetti.	
RESPECTAR LA CREATIVIDAD DEL TERAPEUTA. Análisis de una	
Supervisión centrada sobre el Sistema Terapéutico	63
Dr. L. Cancrini.	
COMENTARIO AL ARTICULO "RESPECTAR LA CREATIVIDAD DEL	
TERAPEUTA. Análisis de una Supervisión centrada sobre el Sistema	
Terapéutico" DEL Dr. L. CANCRINI	74
Dr. Adolfo Loketek.	
ENTREVISTA REALIZADA A LUIGI CANCRINI EN 1987	79
Lic. María Rosa Glasserman.	
INFORMACION BIBLIOGRAFICA.	85
INSTITUCIONES QUE ATIENDEN GRATUITAMENTE PROBLEMAS	
DE DROGADICCION.	91



DROGADICCION

Editora invitada:

Lic. María Rosa Glasserman



Las comunicaciones del futuro, hoy.

Cerrito 740, piso 6° - (1309) Buenos Aires
Tel. 37-6242/38-6154 Tlx. 23516 - Fax 389975

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar
AÑO XI - Nº 18 - Noviembre de 1988

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Asistente de Dirección

Lic. Inés Dates

Secretario de Redacción

Lic. Claudio Hirsch

Coordinadora General

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Consejo de Redacción

Maurizio Andolfi (Roma)
Isidoro Berenstein (Buenos Aires)
Rodolfo de Bernart (Floencia)
Donald Bloch (New York)
Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)
Ives Colas (Lyon)
Alberto Eiquer (Bs. As. - París)
Craig A. Everett (Florida)
Jorge García Badaracco (Bs. As.)
Florence Kaslow (West Palm Beach
Florida)
Raymundo Macías (México)
Juan C. Nocetti (Buenos Aires)
Reynaldo Perrone (Rosario -
Argentina, St. Etienne - Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)
Jacques Rudrauf + (París)
Alberto Serrano (Buenos Aires -
Filadelfia)
Mara Selvini Palazzoli (Milán)
Robin Skynner (Londres)
Carlos Sluzki (Bs. As., Berkshire
Massachusetts)
Helm Stierlin (Heidelberg)
Guillermo Vidal (Buenos Aires)
Gerald Zuk (Nueva Orleans)
Israel Zwerling (Filadelfia)
Lyman Wynne (Rochester - USA)
Mony Elka'im (Bruselas - Bélgica)
Luigi Cancrini (Roma - Italia)

Comité de Redacción

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk
Lic. Inés Dates
Dr. Carlos Díaz Usandivaras
Dr. Fernández Moya (Mendoza)

Dr. Lino Guevara (Neuquén)
Lic. Sara B. Jutoran
Dres. Fidel y Elena Lebensohn
(Rosario)
Dr. Rafael Skiadaressis

Director Honorario
Alberto Cattán

Asesor Editorial
Alfredo Carlino

Gerente Comercial
Claudio Sfeir

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Ediciones A.C.E., Casilla de Correo 94, Suc. 28, Buenos Aires, Argentina.

Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor.

Nombre de la Revista registrado como marca.

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nro. 332.195.

Registro Internacional de Publicaciones Científicas. ISSN 0325-5905.

Composición y armado: Patricia Tur Tarizzo y Federico Tatter. Tel.: 27-3018.

Indice

INTRODUCCION	
Lic. María Rosa Glasserman.	7
INTRODUCCION	
Dr. W. Ricardo Grimson.	11
DROGADICCION Y FAMILIA	
Dra. Silvie Angel, Dr. Pedro Angel.	17
COMENTARIO AL ARTICULO "DROGADICCION Y FAMILIA"	
DE S. ANGEL Y P. ANGEL	
Dr. C.M. Díaz Usandivaras.	22
ENTREVISTA REALIZADA EN EL CENTRO DE TERAPIA FAMILIAR	
MONCEAU A SILVIE ANGEL	
Lic. María Rosa Glasserman.	25
CICLO DE VIDA Y ABANDONO. El vacío espiritual de la adicción	
a la heroína	
Ph.D. Sandra B. Coleman, A.C.S.W. J. Doreene Kaplan, Ph.D. Robert	
W. Downing.	33
COMENTARIO AL ARTICULO "CICLO DE VIDA Y	
ABANDONO" DE S.B. COLEMAN, J.D. KAPLAN Y R.W. DOWNING	
Dr. Juan Carlos Nocetti.	56
RESPECTAR LA CREATIVIDAD DEL TERAPEUTA. Análisis de una	
Supervisión centrada sobre el Sistema Terapéutico	
Dr. L. Cancrini.	63
COMENTARIO AL ARTICULO "RESPECTAR LA CREATIVIDAD DEL	
TERAPEUTA. Análisis de una Supervisión centrada sobre el Sistema	
Terapéutico" DEL Dr. L. CANCRINI	
Dr. Adolfo Loketek.	74
ENTREVISTA REALIZADA A LUIGI CANCRINI EN 1987	
Lic. María Rosa Glasserman.	79
INFORMACION BIBLIOGRAFICA.	85
INSTITUCIONES QUE ATIENDEN GRATUITAMENTE PROBLEMAS	
DE DROGADICCION.	91
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES.	94

Introducción

En 1985, y a raíz de una presentación que efectuara relacionada con este tema en el Congreso de Terapia Familiar en San Juan, fui invitada por el Dr. Alfredo Canevaro a editar este número de la revista. Aunque el área drogadicción no constituye el centro de mi actividad profesional acepté este desafío porque entiendo que el abordaje familiar es esencial para la resolución terapéutica de muchos de estos casos.

El tema es sin duda arduo, no hay aún respuestas absolutas, ni creo que alguna vez se pueda elaborar un sólo modelo de intervención.

Se trata de un fenómeno muy complejo donde concurren aspectos individuales, familiares, socioeconómicos y también políticos.

El criterio que he utilizado para la selección de trabajos fue su referencia específica a la temática convocante en este número, esto es, experiencias de tratamientos de drogadicción, encarados a través de la terapia familiar; sin importar la orientación teórica que cada uno de los autores sustenta.

Por su participación en la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfico y el Abuso de Drogas solicité al Dr. Wilbur Ricardo Grimson que se hiciera cargo de la introducción. Entiendo que por su formación específica en el tema, él nos da una visión panorámica del estado actual asistencial del problema en la Argentina.

Con referencia a los trabajos seleccionados en esta presentación debo decir que he incluido en la misma sólo algunos trabajos extran-

jeros. Hay mucha tarea realizada en el país en rehabilitación de drogadictos: terapias individuales con distintos abordajes, comunidades terapéuticas, orientación a la familia, etc., pero quizás reconociendo la posibilidad que no haya efectuado una búsqueda exhaustiva, no hallé abordajes en este tema generados en la terapia familiar.

El trabajo de los Dres. S. y P. Angel, es una síntesis elaborada por los autores, proveniente de un artículo más extenso que data de 1985, fecha en la cual tuve ocasión de entrevistar a la Dra. S. Angel en el Centro Monceau en donde realiza su tarea. La versión de dicha entrevista complementa con muchos datos adicionales el modo de trabajo de este grupo.

El trabajo de Los Dres. Sandra Coleman, J. Doreene Kaplan y Robert Downing basado en una investigación que incluye 111 individuos divididos en 3 grupos poblacionales trata sobre la función de la adicción a la heroína como un modo adquirido en la familia para sobrellevar la separación, pérdida y muerte a lo largo del ciclo vital familiar.

Uno de los aportes básicos de este trabajo —según mi criterio— es introducir algunos elementos conceptuales acerca de las separaciones tempranas y la transmisión intergeneracional de conductas.

Un ángulo interesante del problema —el análisis de la compleja intervención de un supervisor es encarado por el Dr. L. Cancrini en su trabajo, quien insiste en el respeto por la creatividad del terapeuta. Probablemente el material de la entrevista, constituya un aporte adicional de mucha riqueza al proponer una categorización de 4 grupos de drogadictos, acompañados de una indicación terapéutica específica para cada uno de ellos. Estos 3 trabajos son sucedidos por los comentarios elaborados por tres terapeutas familiares argentinos.

El primero de ellos responde a la autoría del Dr. Carlos Díaz Usandivaras profesional de reconocida capacidad en el tema.

El segundo fue elaborado por el Lic. Juan Carlos Nocetti, quien a pesar de no ser un especialista en el tema, posee una capacidad creativa conocida y sus aportes siempre son estimulantes.

Por último, se incluye el comentario del Dr. Adolfo Loketek, quien hace referencia al precitado trabajo del Dr. L. Cancrini. Sus puntos de vista interesan en particular por la similitud de funciones como supervisores en el tema.

A continuación y como una contribución documental se agregan dos anexos que entiendo pueden ser de utilidad informativa; el primero es una reseña bibliográfica elaborada sobre la base de algún material disponible y el otro, es un listado de organismos de consulta a

quienes se puede acudir en Buenos Aires.

Pienso, finalmente que mi propio aporte como editora de este número es haber intentado una apertura para el conocimiento y abordaje de esta temática que precedentemente he calificado como ardua.

Mi objetivo es establecer un punto de partida estimulante para iniciar una etapa de avance en la profundización de este complejo problema.

Lic. MARIA ROSA GLASSERMAN
Abril de 1988

Introducción

Poner un tema en perspectiva define el lugar del observador. Y ese lugar —en mi caso— tiene sesgos y preferencias. Tal vez lo que uno haga no sea sólo describir el campo sino —tal vez sólo— el bastión de observación. O el catalejo.

Se observa que la droga está disponible en múltiples formas en nuestro país. No sólo a través de las farmacias que canalizan con mayor o menor conciencia la presión del mercado industrial sino a través de la formidable distribución de drogas ilegales.

Dos distorsiones recientes introducidas en el campo y que son de mal pronóstico son: la venta de muestras de productos alcohólicos que están disponibles en los kioscos de golosinas, y la desenfrenada competencia que los cerveceros han desplegado no contra las bebidas alcohólicas sino para captar los sectores consumidores de gaseosas: vale decir juveniles.

Frente a esto: la indiferencia. O sea que se puede —por ahora— vender muestras de whisky a los niños y también se puede observar como la publicidad capta a los adolescentes sin que nadie grite "foul".

Mientras tanto el CENARESO —que fuera el Hospital Militar— y que tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados, no ha podido constituirse en ejemplo de nada en todos estos años más que de lo que Olivienstein diría con brevedad: "Una institución para clausurar".

Fuera del Estado dos proyectos de envergadura: El Programa Andrés de Carlos Novelli y Viaje de Vuelta de Jorge Castro, dos funda-

ciones de inspiración espiritual que han avanzado en la constitución de comunidades terapéuticas manejadas por adictos recuperados. Juntas representan cuatrocientas camas para el tratamiento de adictos mientras que el CENARESO con masivas dosis de personal sólo cubre breves decenas.

En medio de todo este esfuerzo multivariado una persona que es también una institución —Enrique de Vedia, el Secretario de Desarrollo Humano y Familia— actúa de conector, promotor, amalgamador. Demuestra que el Estado no es siempre sordo e insensible a lo que haya surgido en su periferia. Apoya, crea recursos, otorga subsidios, busca predios utilizables, canaliza energía y constituye un interlocutor válido y valioso en la solitaria tarea de los que trabajan para recuperar adictos.

En tanto la Comisión Nacional (contra el Narcotráfico) trata de coordinar esfuerzos aunque no siempre obtiene que sus propuestas sean respaldadas por la eficiencia ministerial indispensable para trasponer el campo de las buenas intenciones y llegar a formular políticas eficaces a nivel nacional. Sin embargo constituye el ámbito privilegiado por el cual debe pasar la integración de esfuerzos públicos y privados, de organismos oficiales y entidades fundacionales, de personas y proyectos.

Frente a este panorama de predominante desarrollo de esfuerzos asistenciales —al que se suman Gradiva, ACIAR y la Comunidad Terapéutica Vicente López— y del que excluyo proyectos exclusivamente lucrativos, también viene desarrollándose una acción preventiva sostenida. Iniciada hace muchos años por el Fondo de Ayuda Toxicológica —que también cumple un rol en el tratamiento ambulatorio de las adicciones— esta tarea ha sido continuada por diversos tipos de organizaciones como APPUE (la Asociación de Padres para la Prevención del Uso de Estupefacientes) —a la que se ha sumado la pionera en la prevención educativa Prof. Graciela Meroni—, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psicólogos, CIAP, el Centro Médico Psicológico Buenos Aires y el Centro de Prevención de Vicente López. Estos diversos organismos se han nucleado en el Subcomité de Prevención de la mencionada Comisión Nacional estableciendo algunos de los lineamientos de las políticas nacionales de prevención y, modelando el tipo de acciones a poner en práctica: Jornadas, cursos de capacitación, etc.

El panorama es diverso y según las preferencias del observador puede ser descripto como “variado”, “confuso”, “contradictorio”, “incierto”. Tal vez reúna una pizca de cada una de estas caracterís-

ticas. Lo que importa es desplegar el futuro en una visión prospectiva que sume elementos creativamente o señale la inutilidad de recorrer determinados caminos si resultan estériles.

Debemos agregar la presencia aún algo fantasmática pero cada vez más corpórea, de dos programas internacionales con interés en sentar reales en el país: el programa UOMO de Juan Corelli y Mario Picchi, que con el apoyo de fondo de las Naciones Unidas ha empezado a entrenar operadores para comunidades terapéuticas en Roma (15 de ellos viajaron en enero de este año por seis meses); y el programa DAYTOP con sede en Nueva York que próximamente hará un primer desembarco después de algunas visitas, gestiones e intercambios.

Creo que el tema del futuro inmediato es: como se puede hibridar fértilmente la multiplicidad de proyectos en forma tal que el beneficio sea del país en su conjunto. Una de las puntas es estar atento a todos estos desarrollos y a que el crecimiento particular de cada uno de ellos esté en beneficio del conjunto. Pero como profesionales no es mucho más lo que podemos hacer aquí.

En cambio desde nuestras instituciones, por ejemplo las que agrupan a profesionales como APBA, la Sociedad de Terapia Familiar, CEFYP, etc., podemos tomar la responsabilidad de fomentar un acercamiento mutuamente beneficioso con programas como los de Novelli y Jorge Castro. Hay mucho que aprender del desarrollo de experiencias que están centradas en la recuperación de la identidad del sujeto a través del desarrollo de lo normativo. La primera impresión (que luego cambia), es que tales desarrollos están cerca del conductismo y behaviorismo. Creo que esa impresión es superficial y encierra una descalificación simplificadora.

La norma inspirada en el cuidado de la persona y establecida y mantenida por un sistema comunitario de libre discusión y confrontación apunta al rescate de la disgregación personal, opera sobre la ansiedad confusional induciendo islotes significativos donde antes reinaba el caos indiferente, y resulta reparador.

Una de las dificultades que se le plantean al profesional de nuestro campo es entender la dimensión psicológica de un planteo que no es primariamente psicológico —porque se basa en el reordenamiento social de la conducta— pero que tiene una consecuencia en el psiquismo que debemos poder desentrañar.

Si esto nos resulta interesante podemos recibir el fenómeno en nuestro seno y abordar su comprensión desde nuestra perspectiva. También podemos acercarnos a los programas mencionados de comunidad terapéutica y poner nuestro conocimiento al servicio de esos proyectos.

Durante muchos años el desarrollo en el mundo de los programas de Comunidad Terapéutica para Adictos, repitió el modelo de aislamiento del mundo profesional que caracterizó al Alcohólicos Anónimos. De ahí que Synanon, Daytop y otros programas no contaran inicialmente con profesionales en su seno, pero la tendencia se está revirtiendo ligeramente y la mayor parte de los programas del mundo entero utilizan profesionales en algunas áreas, y específicamente en el área de la terapia de la familia del adicto. Esto marca una posibilidad, un camino, una integración posible. Durante los últimos años he apostado a esta interacción poniendo en contacto a los organismos profesionales con visitantes extranjeros. Juan Corelli tomó contacto con CEFYP y con la Sociedad de Terapia Familiar. Espero que la gente de DAYTOP realice iguales contactos. No nos viene mal tomar contacto con proyectos mundiales que son guía en su campo y que están teniendo repercusión en experiencias locales.

Aconsejaría a los profesionales que se interesan en el tema que visiten a Diego Gaynor del Programa Andrés y algunas de las experiencias de Viaje de Vuelta. Creo que esas visitas tienen una elocuencia superior a las palabras que yo pueda acercarles.

Otro de los puntos de eventual preocupación es la presencia de elementos espirituales en el manejo de estos programas que de alguna manera choca con los prejuicios predilectos de nuestro andamiaje profesional laico. Quisiera comentar que por un lado son menos omnipresentes a medida que los programas crecen (ésta es una experiencia verificable además en el plano internacional), y por otro lado no afectan el programa en cuanto a su desarrollo estrictamente terapéutico si son *soporte* del terapeuta y no instrumento de su accionar operativo.

Los argentinos somos en conjunto una sociedad poco solidaria, poco preocupada por el destino de nuestros semejantes, donde sobreviven formas de atención en el campo de la salud y de la salud mental que en la mayor parte de los países comparables han sido superadas (véase al respecto la inmodificabilidad de nuestros Hospicios que en su conjunto parecen más museos sobre formas superadas de la psiquiatría manicomial que exponentes de un país preocupado por su funcionamiento). Tenemos un sistema educativo cuya profundización nos debe preocupar y sin embargo su transformación no ha movilizado el interés común. Nuestra estructura económica nos acerca más a las múltiples formas de la sobrevivencia que la preparación y capacitación para futuros productivos. Cualquier observador ingenuo diría que el futuro del país debe ser motivo de deliberación. Sin embargo el pasaje de día a día sustituye a la planificación, a la organización de recursos, a la capacitación sistemática. O sea están

dadas las condiciones para que pasemos a ser un país cuyos sectores juveniles sufran una anomia marcada, pasen por la desesperación y recurran a salidas mágicas.

Frente a esto la prevención del uso indebido de drogas se propone obtener en un marco de responsabilidad una reflexión sobre cosas que deberían preocuparnos como ser los modelos de comunicación familiar, las dificultades para la capacitación profesional y la orientación laboral. Quienes nos interesamos en la prevención buscamos una sociedad más participativa y que se haga responsable de su desarrollo, de su crecimiento. Que modifique los modelos que brinda a los jóvenes, los tratamientos abandonicos que proporciona a sus poblaciones de tercera edad. Que reflexione sobre la tendencia mágica a utilizar medicamentos como si hubiera solución farmacológica a problemas cuya índole no es química.

No estamos en otro lado, en otro tiempo, en otra realidad. Es posible que haya algo de eso. Pero en tanto los problemas estén ante nosotros ejerciendo con su mera presencia un desafío, estamos tentados de decir que nuestra respuesta está ligada a nuestra identidad como ciudadanos responsables de haber adquirido una capacitación profesional. Es cierto que nuestro programa puede resultar ingenuo. También es cierto que resulta convocante de profesionales y no profesionales, que sus acciones son aceptadas, sus políticas difundidas, su operación solicitada.

Será tal vez que nuestro discurso hace caso omiso de determinantes particulares porque quiere recortarse en una visión mejor del conjunto social. Será nuestra forma de decir desde la prevención aquí estamos trabajando para un futuro mejor en el que tal vez nuestra tarea ya no sea tan necesaria.

*"Aquí estamos
tu y yo
tratando de cambiar el mundo"*

Patricia Sosa ("La Torre")

Dr. W. RICARDO GRIMSON



CEFYP

Centro de Familias y
Parejas

Director General
Dr. Adolfo Loketek
Directora de Asistencia
Lic. María R. Glasserman
Directora de Docencia
Lic. Alba Schabas

Billinghurst 1867
Tel. 825-1562

Congreso Interno Abierto '88 LA INDICACION

- Indicación y Contraindicación de Terapia Familiar
- Terapias Simultáneas: Indicación
- Criterios para la Finalización del Tratamiento
- Recontrato - Reconsulta

Fecha: Sábado 10 de diciembre de 9 a 14 hs.

Dirigido a: Profesionales de la Salud Mental

Inscripción: en Secretaría hasta el 30 de Noviembre.

Arancel:

Miembros de CEFYP \$ 25.-

No miembros de CEFYP \$ 50.-

Drogadicción y Familia

Dra. SILVIE ANGEL

Psiquiatra hospitalaria.

Dr. PEDRO ANGEL

Director Médico del Centro de Terapia
Familiar Monceau.

Traducción: Paul Raschenberg.

Proponemos un acercamiento mutidimensional a un fenómeno tan complejo como la toxicomanía. Para nosotros, los enfoques epidemiológicos, sociológicos, biomédicos y clínicos son complementarios.

Los clínicos han orientado sus esfuerzos sobre todo hacia el enfoque fenomenológico y psicoanalítico como así también hacia las técnicas de tratamiento más apropiadas para ayudar a los toxicómanos. Se creó una red institucional que ofrece diversas modalidades de atención. En el marco de varios de estos sitios de tratamiento nos llamó la atención lo intrincado de los lazos que unen a los jóvenes toxicómanos con sus familias. A diario, los padres exigen a los terapeutas respuestas inmediatas a los múltiples interrogantes planteados por la drogadicción de sus hijos. Nuestra doble formación tanto psicoanalítica como sistémica, nos ha llevado a proponer a estas familias un

abordaje específico: la terapia familiar.

Dos poderosas razones nos han llevado a elegir este enfoque para numerosos drogadictos.

A menudo, los grupos de padres reproducen las interacciones patógenas que colocan al joven en situación de chivo emisario. En cuanto al abordaje individual del drogadicto, las dificultades son evidentes. Los adolescentes no toleran el encuadre psicoanalítico y los drogadictos menos aún. Ellos no formulan ningún pedido, en particular cuando aún son dependientes de uno o varios productos. Aún si se lleva a cabo una psicoterapia, el entorno no la acepta y los padres no dejan de boicotearla a través de manejos ingeniosos donde lo actuado es igualmente privilegiado.

El abordaje familiar resulta particularmente adecuado en lo que concierne al drogadicto quien a menudo, con conductas de víctima, revela un sistema familiar disfuncional, y reorganiza alrededor de estos pasajes al acto, modalidades transaccionales cada vez más rígidas pudiendo ir al encuentro de su autonomía.

En efecto, la imagen mítica del drogadicto en ruptura con su familia se opone al doble grado de autonomía que muy a menudo se encuentra en estos jóvenes para quienes la violencia de las separaciones alterna con la frecuencia de las reconciliaciones fusionales. Es a partir de estas verificaciones que se funda el Centro Monceau, especializado en el acercamiento familiar de los drogadictos.

Las consultas son gratuitas y se respeta el anonimato. Diez terapeutas con dedicación parcial (cuatro jornadas y media en total), tienen a su cargo los dos consultorios. Dos personas se encargan de la re-

cepción y de la secretaría.

Los consultorios cuentan con dos grabadores para grabar las entrevistas y uno de ellos con un espejo unidireccional. Desde luego, previo a cada sesión, se aclara a las familias que consultan cuáles son las características de la misma.

Desde 1980, cerca de novecientas familias fueron entrevistadas en este marco, para delimitar nuestro tema trataremos de circunscribirnos a las modalidades transaccionales y al acercamiento terapéutico de familias de dependientes de heroína que constituyen el 90% de nuestra clientela. Aclaremos que no se trata en absoluto de trazar un perfil único y patognómico sino de encontrar puntos nodales específicos a menudo insertados en la mayoría de las historias familiares. Este enfoque es, desde luego, un complemento de las otras modalidades de atención existentes.

La mayoría de las familias no alegan ningún otro síntoma más que la drogadicción de uno de sus hijos para justificar la entrevista. Pero, a menudo, el análisis del sistema familiar pone de manifiesto distintos patologías en uno o varios de sus miembros.

La anamnesis detecta la existencia de numerosos antecedentes psicopatológicos en uno o varios miembros del grupo familiar: cerca del 50% de los padres han presentado problemas psiquiátricos más o menos notorios: sintomatología neurótica aguda, estados depresivos, a veces con tentativas de autodestrucción o alcoholismo, incluso de drogadicción (opio, barbitúricos).

Las investigaciones epidemiológicas pusieron en evidencia el uso exagerado de psicofármacos en los padres de los drogadictos. Verificamos que a menudo ésta

es la realidad; hemos observado igualmente que numerosos adolescentes utilizan precozmente sedantes recetados ya sea por un médico, ya sea muy a menudo por sus padres.

Muchos casos nos han demostrado que los psicofármacos pueden ser utilizados como reguladores de conflictos interfamiliares e incluidos como tales en el sistema de comunicación.

Otro hecho notable es la frecuencia de dificultades psicológicas observadas en la fratria del drogadicto. En más de una familia sobre dos, se observan problemas de delincuencia, de depresión con intentos de suicidio y de dificultades en los hábitos alimenticios. En un 15% aproximadamente de los casos, uno o más hermanos son o fueron drogadictos.

La negación del entorno es uno de los puntos, sistemáticamente más detectado. Puede prolongarse desde varios meses hasta varios años. Aún cuando trate de disimular la intoxicación, el joven envía toda una serie de mensajes a su familia (robo de dinero, olvido de jeringas...), que ésta no quiere o no puede descifrar.

Estos mensajes de registro no verbal traducen una de las características de estas familias. Lo que se muestra es más importante que aquello que se dice.

Por más chocante que pueda resultar esta hipótesis, la drogadicción puede constituir un beneficio para los diferentes miembros de la familia. En tanto el equilibrio familiar no sea amenazado por accidentes o incidentes, todo transcurre como si el drogadicto no fuera el único en vivir su "luna de miel" con la droga. En efecto, después de las tormentas asociadas a los intentos de autonomía del adolescente, los padres vuelven a encontrar a un joven cuya capacidad de rebelión está de-

bilitada, incluso anulada. Debido a sus efectos ansiolíticos y euforizantes, la heroína permite un acercamiento con el padre más comprometido. Estas observaciones nos llevan a pensar que los adolescentes son víctimas inocentes de padres patógenos. De hecho, estos jóvenes son parte integrante de un sistema disfuncional donde, sucesiva o simultáneamente, los distintos miembros de la familia utilizarán un síntoma o una enfermedad como mecanismo regulador.

Cualquiera sea el motivo, el joven "culpable consistente" asume la culpabilidad de la familia, además de la suya propia.

Sueña con ocupar un escenario en el cual fue ubicado como protagonista cargando con todos los males, sin embargo, no puede llegar demasiado lejos con una carga alrededor de la cual gravita una constelación familiar debilitada.

El mito de la buena armonía familiar será mejor representado cuanto mejor cumpla el joven su función. Toda desavenencia conyugal, todo fracaso escolar de un hermano menor, toda depresión de un abuelo son ignorados: la familia describe un funcionamiento idílico que se ve perturbado por la conducta de un drogadicto, conducta cuya responsabilidad es inmediatamente adjudicada a factores externos (grandes traficantes, malas compañías).

La violencia, auto o heteroagresiva, revela a menudo la multiplicidad de transgresiones que se repiten de una generación a otra. Tanto en la relación a la justicia como a las normas morales, estas transgresiones a menudo son mantenidas en secreto.

De esta manera, y en el transcurso de la terapia hemos descubierto que un abuelo idealizado estuvo preso durante un año

por violación, que otro con el juego había arruinado a su familia, que un tío tuvo el honor de ser considerado por el periodismo, el enemigo público Nº 1. La revelación de estos secretos durante la sesión constituye un momento muy importante del trabajo clínico y debe ser restituida tanto en la historia familia como en el proceso terapéutico.

Estas familias de funcionamiento rígido parecen estar fascinadas por la desviación y la marginalidad: muchos padres fantasean los excesos sexuales de sus hijos cuando en realidad, éstos confiesan una vida de relación y sentimental muy pobre desde que son dependientes de la heroína.

La intrusión de los padres en la vida fantasmática de los jóvenes es casi constante. En el transcurso de las entrevistas se detecta su necesidad de controlar el espacio psíquico del hijo. La dependencia con el producto limita esta intrusión y preserva al drogadicto de relaciones demasiado erotizadas establecidas con uno de los padres.

Desde una óptica sistémica, la eliminación de las barreras generacionales, las transgresiones repetidas en la historia familiar, las fuertes relaciones de dependencia de los padres con la generación anterior constituyen un contexto propicio para la aparición de relaciones para-incestuosas.

En estas familias, la promiscuidad entre las generaciones no sólo no es denunciada, sino que es objeto de una valorización.

Desde este punto de vista, la drogadicción permitirá tanto mejor hacer un impasse sobre los deseos incestuosos dado que tiene por función enmascarar los conflictos latentes de la pareja parental dan-

do lugar a seudo unión para ayudar al hijo enfermo. La ruptura implícita del pacto incestuoso parece desencadenar bien a menudo las violencias intrafamiliares.

El síntoma de la droga cumple admirablemente la función de limitar el proceso de individuación del joven. Lejos de favorecer al logro de la autonomía, la dependencia a la heroína duplica y refuerza la dependencia afectiva a la familia.

Las lealtades invisibles que ligan el paciente designado a sus ascendientes confieren una seudo plasticidad al sistema familiar. Aparentemente en movimiento, este sistema está dotado de una gran rigidez. La cohesión se logra alrededor de la espera, de la aprehensión del retorno o de la partida. El drogadicto personifica este presente-ausente necesario para la homeostasis familiar. Regularmente lo observamos en el transcurso de las sesiones en las que participa, derrotado, desconectado, sin que esto modifique en absoluto las interacciones del entorno.

Autonomía imposible - separaciones imposibles. Estos sistemas familiares no se deforman más que para reformarse mejor. Normalmente la familia hace la consulta frente a una situación de crisis: el pedido manifiesto es una cura de desintoxicación. Estos períodos de crisis no concuerdan necesariamente con una urgencia somática del joven.

Esta distinción entre crisis y urgencia es tanto más evidente cuanto que un cuadro clínico agudo (coma, descompensación psíquica, septicemia, etc.), no siempre ocasiona un pedido de tratamiento.

Cuántas veces nos sorprendió oír a una madre o a un padre en sesión, banalizar un episodio confuso-onírico o un estado de inconsciencia prolongado sin haber

recurrido a atención médica. Los padres nos desafían: "desintoxíquelo, pero no nos cambie".

La experiencia nos ha mostrado que es inútil detenerse en el deseo del drogadicto de privarse de la droga y que las presiones familiares no podían ser, por sí solas, garantía del éxito de la curación.

La posibilidad de diferenciar la noción de crisis en relación a la urgencia nos permite clarificar la demanda. Nos sorprendió constatar que los deseos de intervención que siempre aparecen en primer plano durante la primera entrevista desaparecían a menudo en provecho de modalidades de tratamiento de desintoxicación realizadas a domicilio.

El equipo terapéutico, que excepcionalmente interviene en las condiciones materiales de desintoxicación, jamás indica esta posibilidad. La organización de esta etapa refleja las reglas implícitas específicas de cada familia. Asistimos a un refuerzo en las alianzas transgeneracionales en las que se destacan las conductas erotizadas (masajes, cuidados y vigilancias corporales).

Cada familia desarrolla una idea de cómo realizar la supresión de la droga dando testimonio de su creatividad: una familia organiza turnos de vigilancia, una madre dejará de trabajar para llevar lejos a su hijo, una hermana será designada para estar a la cabecera de su hermano en tanto que la madre prepara inyecciones con extracto de hígado.

Cualesquiera que sean las modalidades, la supresión de la droga no modifica en absoluto la homeostasis familiar.

A veces, la familia se desmoviliza y no valoriza los esfuerzos logrados por el joven: "paró, ¿y ahora?". Cada vez exige más y subestima los riesgos de una recaída.

da. En otros casos, aparece un consenso nuevo: todos los problemas están resueltos y la familia desea interrumpir el proceso terapéutico.

MODALIDADES TERAPEUTICAS

Como en todo compromiso terapéutico, el establecimiento de un encuadre constituye una primera etapa de estructuración. Entrevistamos a las familias en sesiones más o menos espaciadas según la problemática planteada. Igualmente, si se desea la presencia de todos los miembros de la familia nuclear en cada sesión, tomamos en cuenta las particularidades de cada sistema familiar.

La duración promedio de las terapias es de alrededor de 7 a 12 entrevistas (un año, un año y medio). Sin embargo, no hay que confundir rigor con rigidez. Es por este motivo que tratamos de adaptar nuestras modalidades de trabajo en función de cada familia.

Esquemáticamente, distinguiremos dos líneas de trabajo:

1) La primera "aquí y ahora" se basa en las interacciones que muestra la familia durante las sesiones. Esto permite detectar en su inmediatez aquello que se juega alrededor de la conducta toxicómana en la dinámica de la familia.

Al principio nos centramos en los problemas planteados por los síntomas del joven, quitando ocuparnos de otras dificultades aún si un conflicto conyugal u otra patología se manifiestan claramente. Es fundamental acercarse lo más posible al pedido de la familia,

tomando en cuenta la realidad del problema de la droga, sin amenazar el equilibrio familiar organizado en torno a la "víctima emisaria".

Indagar acerca de la manera en que cada uno se organiza en torno a la conducta del drogadicto, constituye una excelente fuente de información sobre las alianzas, las lealtades y los mitos familiares.

Mientras subrayamos los riesgos vitales que corre el joven, damos un sentido positivo a su conducta de sacrificio y a su papel de protector del grupo. La movilización de la familia puede dar lugar rápidamente a una desaparición del síntoma. Sin embargo, siempre anticipamos la recaída que se producirá inevitablemente si no hay cambios en el conjunto del sistema.

2) La segunda línea "transgeneracional" hace hincapié en un mejor conocimiento de la historia familiar y tiende a detectar los esquemas repetitivos en varias generaciones.

El rol de los abuelos es primordial. La ingerencia de ellos suele ser directa en la dinámica de la familia (por ejemplo, lazos económicos con sus hijos, la acogida de un nieto con motivo de una fuga o de un tratamiento de desintoxicación...).

Además, muchas de estas familias presentan un problema de desculturación o de aculturación: familias de inmigrantes de 1a. y 2a. generación o bien diferencias culturales entre ambos padres que han aumentado los problemas de identificación del joven.

La historia de la familia y de sus orígenes culturales, elaborada en el

curso de las sesiones, permite al joven drogadicto conectarse con su historia.

A TITULO DE CONCLUSION

Los tratamientos de familias de drogadic-tos, muy a menudo son largos y difíciles. Nos enfrentan permanentemente con la violencia y la muerte.

Comentario al artículo: DROGADICCION Y FAMILIA

De S. Angel y P. Angel.

Dr. C.M. DIAZ USANDIVARAS

Este es un artículo breve que sugiere y promete conceptos muy interesantes pero nos deja con las ganas de un desarrollo más extenso y explícito.

Tal vez su mayor valor es la aguda observación y descripción clínica que evidencia la vasta experiencia de los autores en este campo.

Resulta interesante, aunque conocida, la justificación de la terapia familiar debido al problema de la pseudo individuación del joven drogadicto y su fracaso en el proceso de individuación y autonomía. En este sentido la tarea, centrada en el acercamiento familiar, llevaría finalmente a una separación evolutiva. Las observaciones sobre las características de la familia del drogadicto, su negación, sus tendencias a la farmacodependencia en general: "para todo debe existir algún reme-

Nuestro objetivo es permitir que cada uno de los miembros de la familia pueda desprenderse de los lazos patológicos que los unen entre sí, evitando la proyección de un modelo familiar único.

Una vez concluida la labor terapéutica, la familia con su propia creatividad, produce cambios estructurales que permiten a cada uno desprenderse de procesos demasiado dolorosos, incluso mortíferos.

dio que evite el sufrimiento". La incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, etc., son descripciones ricas y valiosas.

En algunos momentos, tal vez porque no haya sido interés de los autores, faltó un mayor desarrollo teórico que sustentara lo clínico y técnico, así también la explicación sobre cómo logran resolver el difícil problema epistemológico de la integración de la Teoría Sistémica y la Psicodinámica, para que ellas se potencien y no se neutralicen o entren en contradicción.

El párrafo que se refiere a los adolescentes como víctimas inocentes de padres enfermos, merece alguna discusión. Pienso que está influenciado por concepciones causales, lineales, tipo víctima-victimario; que entran en colisión con las concepciones sistémicas referentes a la circularidad. Creo que el proceso de victimización no usa realmente de víctimas inocentes, en cuanto a la responsabilidad por la determinación de las interacciones que sostienen al síntoma. En estas familias es, quizá, donde más dramáticamente se ve que todos sus integrantes son, a la vez, responsables y víctimas de este juego

perverso. Como lo señala Cloe Madanes, la benévola intención de estabilizar, con el síntoma, al sistema, termina por ceder a la explotación del beneficio secundario e independizarse de su función originaria. Esto no implica negar el hecho indiscutible de que aún aceptando la causalidad circular en las interacciones, la situación parentofilial es asimétrica y las responsabilidades parentales son sin duda mayores que las filiales.

Otro punto que creo discutible es la indicación técnica de revelar siempre los secretos familiares. No dudo de la utilidad e importancia de hacerlo, pero sé también de su costo: 1º) la prolongación de la terapia y la demora en conseguir cambios, por un camino útil pero lento, en algunos casos en que la carrera contra la muerte se mide en horas, y 2º) la posibilidad de que la historia sea utilizada por el paciente identificado y aún por su familia, para la construcción de un contexto de justi-

ficación de la conducta sintomática.

En cuanto a las modalidades terapéuticas, destaca dos enfoques diferentes, que supongo son aplicables a distintos tipos de familias. El primero hace pensar en el modelo estratégico-estructural de Stanton, el segundo a los enfoques Bowenianos y a algunos aportes de la Escuela Argentina como el concepto de Transferecia Relacional Dominante y algunos aportes de A. Canevaro. Creo que faltó en la descripción mayor alusión a conceptos estructurales, como referencias al manejo del poder y las jerarquías, a la formación de coaliciones y triángulos perversos, a los fenómenos de triangulación y a la complementariedad; que hubieran enriquecido, aún más, este breve trabajo que recorre, casi todos los conceptos relevantes sobre el tema. En síntesis: despierta deseos de dialogar con los autores para ampliar la información, que su vasta experiencia clínica promete.

**SECRETARIA E INFORMES
DE LA REVISTA
TERAPIA FAMILIAR:
C.C. 94, Suc. 28, (1428) Bs. As.,
Argentina.**



CEFYP

Centro de Familias y
Parejas

Director General
Dr. Adolfo Loketek
Directora de Asistencia
Lic. María R. Glasserman
Directora de Docencia
Lic. Alba Schabas

Billinghurst 1867
Tel. 825-1562

**CURSO FORMACION
TERAPEUTAS FAMILIARES**

AÑO 1989

Dirigido a:
Médicos - Psicólogos - Asistentes Sociales

Taller: GENORAMA DEL TERAPEUTA FAMILIAR
Su relación con la Clínica

Coordinadora: Lic. MARIA ROSA GLASSERMAN
Fecha: 13 y 14 de enero de 1989
Dirigido a: Terapeutas Familiares

**Entrevista realizada
en el Centro de
Terapia Familiar Monceau
a Silvie Angel**

**Por Lic. MARIA R. GLASSERMAN
con Lic. BEBA ROMANO como
intérprete, Noviembre de 1985.**

Desgrabado y traducido: Marianne Cotton.
Buenos Aires, Enero de 1986.

María Rosa Glasserman: *—Me gustaría hablar sobre el funcionamiento del centro, ¿es solamente un centro de drogadicción?*

Silvie Angel: *—Como referencia histórica le puedo decir que se creó en 1980, hace pues 5 años, más exactamente en Noviembre de 1980. De hecho yo trabajaba en el Centro Marmottan que es una institución para toxicómanos, que no se hacía cargo ni de la familia, ni de los padres. La respuesta que se daba a las familias era: "No se puede hacer nada si su hijo no viene".*

En ese momento comencé a darme cuenta que la imagen del toxicómano reflejada por su entorno más cercano era muy diferente a la de los toxicómanos que yo encontraba. Es decir que la imagen mítica era la de jóvenes en ruptura con sus familias que se encontraban ausentes o de viaje mientras que de hecho

eran jóvenes que vivían en sus casas, muy ligados a sus padres en una relación muy conflictuada pero que conservaba lazos, secretos o no, excesivamente importantes.

El segundo punto es lo que hemos dado en llamar "ceguera familiar", es decir el hecho de que la familia no viera a sus hijos drogados en sus hogares así esto durara años.

En aquel momento comencé a recabar información de la terapia familiar. Ya había empezado a trabajar con un cierto número de familias y propuse aplicar el modelo familiar para este tipo de patologías. Luego de dos años obtuve suficiente notoriedad y dinero como para abrir un centro experimental que es el Centro Monceau.

A diferencia de otros centros que reciben solamente a los jóvenes pues piensan que debe haber un lugar para éstos y otro separado para los padres, nosotros hemos elegido realizar un solo trabajo: el familiar. Es decir que no hay medicamentos ni internación. Puede que excepcionalmente haya algunos toxicómanos a los que contremos solos, es decir no únicamente parental. Actualmente hay una docena de terapeutas que trabajan a tiempo parcial y dos secretarías; los terapeutas tienen todos una formación sistémica-analítica.

MRG: *—¿Psicoanalítica y Sistémica?*

SSA: *—Sí, se hizo así, psicoanalítica y sistémica, porque el psicoanálisis en Francia tiene un peso considerable y además porque pienso que es un plus en la formación.*

MRG: *—¿Con qué marco teórico trabajan con los toxicómanos?*

SSA: *—Trabajamos a nivel sistémico.*

Ciertamente, en la elaboración *interviene* a menudo una doble lectura *analítica*, pero a nivel de la intervención *sistémica*: en el encuadre, en el contexto, *en la* de llevar a cabo las sesiones, *en la* lectura, etc.

Por aquí pasaron más de 800 familias. Es un servicio completamente *gratuito*. El centro está subvencionado y *la gente* ni siquiera tiene que desembolsar *dinero*. Cuando nos preguntan si deben pagar algo, les decimos que, si así lo *desean*, pueden hacer una donación a la *asociación*. Aproximadamente una familia sobre diez hace esta pregunta y también *nos* diez hace una donación. Siempre *nos* sorprendemos del hecho que *las familias* que son enviadas por su entorno o por *la educación nacional* o por nuestros colegas, ni siquiera *plantan* la cuestión del costo, lo que *refleja* totalmente su relación con el *dinero* siendo éste un punto fundamental en la *dinámica* de las familias de toxicómanos.

MRG: —¿Qué tipo de toxicómanos son los que ustedes ven?

SSA: —Tenemos aproximadamente un 80% de heroínomanos con una duración de uso de tóxicos superior a 3 años. Se trata de toxicómanos que tienen más de 6 ó 7 años de heroína.

MRG: —¿Cuál es el éxito, la duración del tratamiento familiar, la evaluación y el seguimiento?

SSA: —La única evaluación que hice por el momento es sobre el primer año de funcionamiento, donde consideré tres grupos: los que vinieron una vez, los que vinieron más de cinco veces y los que vinieron entre una y cinco veces. También *y familias* que vinieron por problemas de psicosis, de delincuencia e intentos de

suicidio; es una minoría que también tomamos en cuenta en las estadísticas. Al trabajar sobre esto, nos dimos cuenta que, sacando el primer grupo, es decir aquellos que vinieron solo una vez para la toma de contacto y no volvieron más, en la población de más de una vez tuvimos aproximadamente un 44% de resultados favorables, lo que considero muy bueno.

Tratamos de escribirles, de tener noticias durante bastantes años luego de la terminación del tratamiento, primero escribiendo cartas, luego haciendo un cuestionario de evaluación pero como son muy pocas las familias que responden, consideramos como evolución favorable solamente a aquellas familias de las que tuvimos noticias. A veces esto se da por medios un tanto extraños, como por ejemplo, una chica que habíamos perdido de vista y que por los diarios nos enteramos que era una comediente y le iba muy bien. Por lo tanto consideré aquello un éxito aunque no hubiésemos participado en él.

MRG: —¿Cuántas entrevistas dan ustedes como mínimo y máximo aproximadamente?

SSA: —Son 5 como mínimo, y como máximo tenemos terapias que vienen durando desde hace tres años.

MRG: —¿Con qué frecuencia?

SSA: —En general fuimos cambiando a medida que pasaron los años. Luego del primer contacto, si la familia tiene una pequeña demanda, les damos una segunda cita bastante cercana, es decir 8 ó 15 días después; las tres primeras entrevistas son cada 15 días y luego una vez por mes, si se plantea un problema grave o inquietante los podemos ver nuevamente con una semana de intervalo.

MRG: —En la Argentina por suerte todavía no tenemos el problema de la heroína. ¿Aquí también hacen cockteles con psicofármacos y hay adictos a la cocaína?

SSA: —Tenemos muchos casos. Evidentemente debemos distinguir a los que se inyectan heroína donde hay un riesgo de muerte a corto plazo, de los que utilizan tóxicos: medicamentos, alcohol, hashish, cocaína y LSD en los que el riesgo vital no es para nada el mismo; entonces, de hecho, hay que definir cuál es la patología subyacente, por ejemplo, hemos tenido familias que vinieron por un problema de hashish —que para mí no es un problema de droga—, pero detrás de esta demanda de droga había un problema de estado depresivo muy importante, entonces, de hecho, redefinimos el contexto del problema y consideramos cualquier demanda de la familia, porque en general, si hay una demanda es que hay algo detrás. Hubo dos o tres casos en que hubo que reasegurar a los padres. Tengo el ejemplo de una familia que había escuchado que en el liceo había problemas de drogas y tuvieron miedo de una contaminación, entonces, una entrevista en ese contexto permitió des-dramatizar la situación ya que haciendo la evaluación no encontramos problemas que justificaran que la familia estuviera en terapia, evitanto así, caer en la psiquiatrización de gente que tiene problemas relativos a la sociedad.

MRG: —¿Nunca hubo que internarlos? Y si se interna, ¿quién se encarga?

SSA: —Sí, el problema de internación se plantea seguido. A veces es la familia quien interna al toxicómano en un centro de desintoxicación para toxicómanos, o bien en hospitales generales, por problemas de intentos de suicidio o en períodos

de urgencia.

Hubo otros casos en los que tuvimos que intervenir en terapias breves, proponiendo una internación que en general estaba ligada al hecho de que la familia era muy mortífera, siendo mucho más relevante el riesgo de suicidio a corto plazo que el problema de droga. En esta situación se interviene mucho más como psiquiatra general que como terapeuta familiar.

De todas maneras, trabajamos muy poco con internación, y cuando se lo hace es porque está plenamente justificado. Yo trabajo preferencialmente con internaciones en el Hospital General que conoce muy bien a nuestro equipo y nos envían muchas familias de toxicómanos y de psicóticos. Podemos decir que tenemos un lazo privilegiado con un servicio de internación.

MRG: —... Y que al conocerlos no les desarma el trabajo sistémico, trabajo en equipo, ¿no?

SSA: —Así es, es complementario y tenemos esa apertura, es decir ya sea porque los toxicómanos fueron tratados en otro lugar en un momento dado o porque los padres estuvieron en análisis, en terapia o algo por el estilo.

Nosotros pensamos que es complementario al acercamiento sistémico pero que no tiene ninguna oposición. En algunos casos tenemos contacto con los otros terapeutas y en otros casos, no.

MRG: —¿Quiere decir que ustedes aceptan que el paciente identificado esté con un terapeuta individual?

SSA: —Absolutamente.

MRG: —¿Y lo recomiendan?

SSA: —No se lo proponemos. Si están en terapia decimos que está muy bien y

que está bien todo lo que quieran hacer. No intervenimos para dar consejos.

MRG: —*Sin embargo, hay líneas en que hay gente que no acepta la terapia individual si está en terapia familiar.*

SSA: —Nosotros lo aceptamos porque pensamos que, particularmente en los problemas de drogas pesadas, la terapia individual no cambiará nada; no es entonces un problema que moleste, además no se puede ir en contra de lo que ya fué organizado por la familia. Tratamos de incluirlo como una hipótesis suplementaria.

Tenemos dos familias en las que todos los miembros están en terapia individual, lo que me parece la mejor indicación de terapia familiar. Cuando hay cuatro terapias individuales es que se trata de terapia familiar.

MRG: —*¿Se habla de la droga o no se habla de la droga en la familia? Está la línea de Haley que centra la tarea, el trabajo en los padres se hagan cargo del hijo. Después está la línea de Andolfi que desecha la droga y se habla de otra cosa, como padres. Lo que llama la "vaca sagrada de la familia"; etc.*

SSA: —No trabajamos como Haley, eso es seguro, pero trabajamos mucho con el problema droga y hablamos de la droga sistemáticamente; incluso, si comenzamos a hablar de otra cosa volvemos a la demanda inicial de la familia sistémicamente. Pienso que también nos diferenciamos de Andolfi, si bien aquí hay dos personas que se formaron con el equipo de Roma. Nosotros adaptamos distintos modelos para llegar a una combinación propia y que además difiere según cada terapeuta. Este modelo asocia dos ejes: el primer eje es el aquí y ahora en el que trabajamos sobre lo que pasa en el momento y el se-

gundo eje, que considero fundamental, completamente distinto de Haley y Andolfi y más cercano al nivel teórico de Boszormenyi Nagy y un poco a Bowen que es trabajar sobre lo transgeneracional. Tenemos muy pocas familias en que esto ocurre, pero algunas veces alguno de los abuelos participa en la sesión. Esto me interesa mucho porque creo que ahí es donde se apoya todo el "back-ground" analítico, es decir en las repeticiones transgeneracionales a través de la historia familiar.

MRG: —*Después de Whitaker, Andolfi también trabaja así, con todos los abuelos presentes. Andolfi, como consultor en Buenos Aires, citó a las tres generaciones en 1984.*

SSA: —Es decir que la gente cambia y está bien que la gente cambie y evolucione.

MRG: —*Hay como dos líneas, yo pienso como usted respecto a la terapia familiar como primera indicación para la drogadicción. En Estados Unidos están los Day Top Center, en Italia también está el Proyecto UOMO dirigido por Mario Corelli y Mario Picchi, no sé si acá también. Están trabajando con toda una línea que es la de internarlos y hacerlos trabajar intensamente y con un plan terapéutico que no incluye terapia familiar (1985). Es tipo comunitario. La familia queda como excluida de eso. Tiene un alto nivel de curación y generalmente son ex-drogadictos los que coordinan. Consultan con profesionales pero no son profesionales los que llevan a cabo esta tarea y dirigen estas comunidades. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Aquí se encuentran este tipo de lugares?*

SSA: —En Francia hay muchos lugares así, son lugares donde los toxicómanos

viven y algunos están regidos por antiguos toxicómanos, otros por semi-profesionales o profesionales y a veces por benévolo veteranos o profesores de gimnasia que tienen ganas de vivir en el campo.

Yo no tengo una posición general, sólo tengo posiciones respecto de cada situación. Creo que es muy difícil trabajar con antiguos toxicómanos; en Marmottan los hay y creo que me engañaría a mí misma si considerase que estos antiguos toxicómanos, como los antiguos alcohólicos pueden ocuparse de esta tarea porque son gente joven, frágil y que no tienen otra inserción profesional.

Corren el riesgo de rechazar y de hecho proyectan mucho de su propia patología. Pienso que la heroína no es ningún diploma, probablemente sea mala al decir esto pero es lo que pienso. A menudo sucede que no han analizado su propia motivación y tienen en la comunidad un accionar excesivamente sádico con respecto a otros toxicómanos. Creo que en los problemas de salud mental —y la toxicomanía lo es para mí— debe haber profesionales. Esa es mi idea personal. Por el contrario, en cuanto a reinserción profesional se trate pienso que no estamos en el terreno de la patología y me parece bien que haya otra gente que se organice para poder lograr la reinserción; carpinteros, técnicos de trabajo o antiguos toxicómanos que se han recompuesto es otra cosa, pero cuando se trata de dolencias, de desintoxicación, de compromiso con la vida creo que es mejor que haya gente lo bastante sólida como para que puedan acompañar a éstos jóvenes.

MRG: —*¿Y en los casos graves en los que hay que desintoxicar a los pacientes? ... a la familia no se la puede dejar por-*

que alguna función ese hijo está cumpliendo. ¿Qué hace usted en esos casos?

SSA: —Lo interesante de mi experiencia es que yo salía de un centro en el que la cura de desintoxicación era un momento clave en la historia del toxicómano y todas las demandas de consulta eran para ser internados y desintoxicados. Cuando creé mi centro, pensé que sería un gran problema trabajar con la cura de desintoxicación y que se debía hacerlo con un gran número de hospitales. Lo realmente interesante —y aquí se ve todo lo que nos enseñan las familias— fué que lo fundamental en la primer institución se volvió secundario en la nuestra. Es decir que la mayoría de los heroínómanos se ocupan y buscan su cura por voluntad propia cuando un buen día dicen: "Bueno, ya está, ¡la terminé con esto!". Encuentran un médico clínico, tienen medicamentos y nosotros disminuimos considerablemente la internación.

Es absolutamente sorprendente ver que la cura de desintoxicación es importante pero no es un problema, porque los heroínómanos van a parar una, dos, tres veces, el problema es qué es lo que los hace volver a caer.

MRG: —*¿Ustedes también trabajan en la formación de profesionales?*

SSA: —No, no tenemos gente en formación, trabajamos sólo en la parte clínica. Hacemos investigaciones y damos conferencias pero no nos ocupamos verdaderamente de la formación. Es decir que de hecho hay gente que se forma, pero en el exterior. Esta es una de nuestras originalidades con respecto a otros centros de terapia familiar: éste es un verdadero centro familiar donde hay muchas pero muchas familias respecto a otros centros que tie-

nen grandes actividades de formación y mucho menos de clínica. Nosotros tenemos algo más de 2.000 consultas familiares por año.

MRG: —¿Acá sólo se trata la drogadicción?

SSA: —Nosotros tratamos de estirarnos lo máximo posible como para variar, como el presupuesto es del Estado, somos un centro de toxicómanos pero tenemos algunas familias de anoréxicos, bulimias y tentativas de suicidio pero el 90% son toxicómanos porque somos conocidos como centro de toxicómanos, pero todo el mundo tienen ganas de ampliar un poco la patología.

Yo sigo aquí a todas las familias interesantes que me son enviadas porque tengo un confort laboral y porque es gratis.

En nuestro centro tenemos patologías extremadamente pesadas, las psicosis que nos envían son psicosis graves, gente que ya estuvo en instituciones, que fueron internados, que toman grandes cantidades

de medicamentos a causa de la esquizofrenia, y es por eso que el interés de este centro, que tiene una estructura que funciona bien, es que cuando hay una patología muy pesada podemos difícilmente verla en privado, en un consultorio o algo por el estilo.

MRG: —¿Cuál es el encuadre que utilizan?

SSA: —Apriori nosotros trabajamos con un terapeuta dentro y otro detrás de cámara. Hay algunas familias que veo sola, a veces trabajamos de a dos por una razón con alguna familia pero en general es con uno en sesión y el otro afuera. Creo que está bien que haya un eje que dirija, además de variar un poco y sobre todo no hay que confundir rigor con rigidez. Hace falta rigor para saber lo que intentamos hacer pero podemos variar los modelos, como la duración de las sesiones, el ritmo y el contexto mismo del trabajo.

**PARA PUBLICIDAD EN ESTA REVISTA
DIRIGIRSE POR CARTA A:
C.C. Nro. 94 - Sucursal 28
(1428) Buenos Aires - ARGENTINA**

Carlos Srebrow y Asociados

Asesores en análisis y desarrollo organizacional

COUNSELING GRUPAL (Grupos de asesoramiento y desarrollo compartido)
Dirigentes de Empresas Familiares · Dueños de Empresas Unipersonales · Directivos de Instituciones y Asociaciones · Líderes y Conductores de Grupos de Trabajo · Profesionales Independientes.

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO
Pequeña y Mediana Empresa
Empresa Familiar
Asociaciones e Instituciones
Persona y Rol Profesional

GRUPOS DE ESTUDIO
Introducción al Análisis Organizacional
Teoría y Práctica del Análisis Organizacional · Escuelas y Marcos Conceptuales del Fenómeno Organizacional
Empresa y Familia.

CAPACITACION
ORIENTACION OCUPACIONAL

SUPERVISION
INTERCONSULTAS

NUEVA DIRECCION
Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 2255
(1425) Bs. As. - Tel. 72-3866



TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

Curso bianual de entrenamiento. Da formación básica en Terapia Sistémica. Incluye clases teóricas y de Entrenamiento Vivencial. Cámara Gessel y Video. Dirigido a Psicólogos y Médicos.

TALLERES

**CENTRO
INVESTIGACION
FAMILIAR**

- I. De Entrenamiento Vivencial.
- II. Profundización Clínica.
- III. Introducción al Pensamiento Sistémico.

Directora
WANDA SANTI

DEPARTAMENTO DE EXTENSION COMUNITARIA

- Charlas para profesionales.
- Tratamientos familiares y pareja.
- Area Prevención.
- Son servicios GRATUITOS que da la Institución.

CONSULTAR — ABIERTA LA INSCRIPCION

Azcúenaga 964 2º C

1115 Buenos Aires - Argentina

Teléfono 961-4295

Ciclo de Vida y Abandono.

El vacío espiritual de la adicción
a la heroína.

Ph.D. SANDRA B. COLEMAN

Directora del Centro de Guía Familiar del
Distrito de Bucks, Riverview Plaza, suite 203,
River Road, Yardley, Pennsylvania 19067; y
Profesora clínica asociada de la Universidad de
Hahnemann, Philadelphia, Pennsylvania.

A.C.S.W. J. DOREENE KAPLAN

Directora asociada del Centro de Guía Familiar
del Distrito de Bucks, Yardley, Pennsylvania.

Ph.D. ROBERT W. DOWNING

Profesor asociado de Psicología en Psiquiatría
de la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia,
Pennsylvania.

Este estudio fue financiado por DHHS Subven-
ción N° R01-DA-02332-02, Departamento de
Investigación, Instituto Nacional de Abuso de
Drogas. Esta investigación se realizó mientras el
primer autor era Director de Investigación y el
segundo autor era asociado de Investigación en
ACT (Achievement through Counseling and
Treatment), una división de servicio profesional
y de empleo judío, Philadelphia, Pennsylvania.
Quisiéramos agradecer la contribución de Paul
R. Gallagher, miembro del equipo de investiga-
ción.

Artículo traducido de: Family Process 25:
P. 5-23, 1986.

Traducción: Lic. Carola Forrester.
Revisión: Inés Dates.

Así como la vida de un individuo es vista
como una secuencia de etapas que requie-
ren del dominio de tareas de desarrollo,^{1 7}
la familia también puede ser vista como

enfrentándose a una serie de tareas inter-
dependientes, relacionadas con estadíos,
que el sistema como un todo debe domi-
nar. Carter y McGoldrick⁴ sugieren que
la disfunción familiar aparece más proba-
blemente cuando la tensión normal del
desarrollo coliciona con el stress transge-
neracional. Uno de los eventos más trau-
máticos para la vida de una familia es la
muerte o pérdida de un miembro signifi-
cativo. Eisenstadt^{1 6} ha propuesto que la
muerte de uno de los padres durante la
niñez puede dar como resultado la genia-
lidad si dicho duelo es "llevado en forma
creativa". El reconstruyó perfiles de pér-
dida paternal/maternal demostrando que
tantos personajes eminentes como delin-
cuentes eran huérfanos en una proporción
mayor a la esperada.

La información sobre delincuentes su-
giere que la incapacidad para "sobrellevar
el luto en forma creativa" puede resultar
en conductas desviadas.

En los últimos años la literatura revela
una asociación interesante entre la con-
ducta a raíz del abuso de drogas y la pe-
na no resuelta.⁵⁻⁷⁻²⁴⁻¹¹⁻²⁵⁻²⁸⁻³⁰⁻¹⁸⁻²¹
Repentinamente se sugirió que la muerte
no elaborada, así como otros factores de
pérdida o separación, cumplen una impor-
tante función familiar, especialmente en
familias de los adictos a la heroína. Cole-
man y Stanton⁶⁻⁷⁻⁸⁻¹²⁻²⁶⁻²⁹ han escrito
sobre los elementos conflictuales de la se-
paración, notando que el uso de drogas
se intensifica durante la adolescencia
cuando los conflictos de separación alcan-
zan un pico.

En un estudio clínico anterior, Cole-
man⁵ encontró que el 72 por ciento de
una muestra de familias de drogadictos
habían sufrido la pérdida de por lo menos
un miembro en forma inesperada o trau-

mática, y que ninguna de estas familias compartía una filosofía o religión que les facilitara sobrellevar el duelo saludable-mente. Esta observación concuerda con los estudios de Blum y Asociados² que muestran una mayor incidencia religiosa en familias de jóvenes con menos riesgo de abuso de drogas que en aquellos jóvenes con más riesgo. Por lo tanto la hipótesis de Coleman³ al sistema familiar con un mecanismo para hacer frente a la falta de esperanza y desesperación.

Otro estudio piloto⁹ reveló que el 52,4 por ciento de una muestra de pacientes drogadictos habían perdido por lo menos a un padre o hermano antes de los 24 años del paciente, una diferencia significativa comparada con el 25,9 por ciento de un grupo de control de estudiantes graduados y el 17,6 por ciento de una muestra de empleados en programa de tratamiento de droga, una diferencia estadísticamente significativa ($p < .05$).

Este estudio¹¹ es el primero que investiga en forma sistemática el rol de la muerte, pérdida y separación en el contexto del ciclo de la vida familiar de los adictos a la heroína, pacientes psiquiátricos externos y estudiantes secundarios normales. Está basado en la premisa teórica de que la ingestión de drogas sirve al mantenimiento de la homeostasis familiar, al hacer que el miembro drogadicto quede desvalido e incapaz de abandonar la familia. Este proceso tiende a unificar y afianzar la integridad familiar. Dentro de una serie compleja de mecanismos de retroalimentación involucrados en la ingestión de drogas hay un sentimiento generalizado de desesperanza y falta de propósito o sentido de la vida que acompaña el ciclo repetitivo de interacciones familiares.

Por lo tanto el ritual de adicción a la heroína pasa a ser intencional y funcional.

PLAN DE INVESTIGACION

Muestra

La muestra estaba compuesto por 111 individuos de tres poblaciones:

a) 40 de un programa de metadón en Philadelphia metropolitano, cada uno presentaba un historial de por lo menos dos años de adicción al narcótico,

b) 40 presentaban un diagnóstico de neurosis o de un desorden de personalidad y se encontraban bajo tratamiento psiquiátrico entre los pacientes externos del Centro Comunal de Salud Mental ubicado frente a la clínica, y

c) un grupo de 31 estudiantes secundarios con simple o doble escolaridad que no presentaban una historia familiar ni de drogadicción, alcoholismo o de desórdenes psiquiátricos. (Nota: Este grupo fue seleccionado cuidadosamente entre un grupo de 80 estudiantes quienes realizaron la batería de pruebas. Debido a que se le dió importancia a las experiencias familiares, fue necesario excluir del grupo "normal" a todo aquel individuo que presentaba antecedentes personales o familiares de drogadicción, alcoholismo o tratamiento psiquiátrico. Los estudiantes restantes ($N = 49$), fueron calificados como "tensionados" y serán incluidos en estudios posteriores como un grupo intermedio). Se utilizaron procedimientos estratégicos al azar para asegurar igual número de hombres y mujeres, blancos y negros. La edad promedio fluctuaba entre los 24,90 años y los 29,47 años y el pro-

medio de años de educación entre los 11,20 años y 13,18 años. En el Cuadro I se detallan más datos demográficos. Los padres de aproximadamente la mitad de los individuos de cada grupo también fueron entrevistados.

Instrumentación

La herramienta principal de la investigación fue el cuestionario sobre los antecedentes familiares, de Coleman (CFBQ¹¹, "Coleman Family Background Questionnaire"), que consiste de una entrevista estructurada, realizada individualmente, que abarca una serie de experiencias del ciclo de la vida familiar. El CFBQ incluye un cuestionario sobre: factores demográficos, religión, sentido de la vida, experiencias ante el dolor, actitudes hacia la muerte, conductas de adicción, relación con figuras paternas, incesto, comodidades habitacionales e hijos. También provee un panorama retrospectivo de los principales acontecimientos de la vida, las respuestas del individuo a esos acontecimientos y su impresión de las reacciones de los otros miembros familiares. Las preguntas referidas a la composición familiar condujeron a la reconstrucción de un "mapa" de los hogares de estos individuos y de aquellos que han vivido con ellos. Por cada miembro familiar fallecido u otro difunto significativo, se especifican las causas de muerte; edad del individuo y del difunto; tipo de relación; impacto emocional y práctico del fallecimiento; grado de duelo del individuo, parientes y hermanos; si asistió al funeral, y su impacto. Se analiza cada separación temporaria o permanente de un miembro familiar para determinar su causa, efecto, el momento en que ocurrió y si el sujeto se reunió con dicho

miembro o no.

Además del CFBQ, se sometió a cada individuo a la Evaluación Rápida de Inteligencia (Quick Test of Intelligence¹), Consecuencia de la Propia Muerte (Consequences of One's Death¹⁵), Temor a la Muerte y al Fallecimiento, de Colett-Lester (Collett-Lester Fear of Death and Dying¹⁹), la Lista de Síntomas de Hopkins (Hopkins Symptom Checklist¹⁴), Propósito en la Vida (purpose in Life¹³), y la Escala de Medio Ambiente Familiar (Family Environment Scale²²).

Análisis de Datos

El CFBQ, junto con los instrumentos de evaluación descritos en la sección anterior, arrojaron 96 variables por medio de los cuales se podía comparar los adictos con los individuos normales y los pacientes psiquiátricos externos. Los exámenes revelaron que 22 de éstas 96 comparaciones eran significativas en un nivel del 5 por ciento o más cuando se analizaban las diferencias entre los adictos y los estudiantes normales. Para la comparación entre los adictos y los pacientes psiquiátricos externos, 20 de las 96 variables reflejaron por lo menos un 5 por ciento de nivel de significación. Ya que se puede contar con que solamente 4,8 de las comparaciones de cada serie ocurran aleatoriamente, existe suficiente evidencia que los adictos difieren de los otros dos grupos de control.

Como un refuerzo para las comparaciones univariadas entre grupos para cada variable evaluada, se usó un análisis funcional lineal discriminativo para obtener información acerca de los focos independientes de discriminación dentro de la serie actual de medidas con su contenido

CUADRO I: Edad, Educación, C.I., Religión, Estado Civil para las muestras de poblaciones.

Variable	Adictos a la Heroína	Pacientes psiquiátricos externos	Estudiantes normales	p ≤
Promedios				
Edad	28.05	29.47	24.90	.001
Años de educación	11.70	13.18	12.91	.0002
C.I.	92.40	94.40	98.60	.001
Porcentajes				
Religión:				
Protestante	33.33	36.84	41.38	
Católico	38.46	47.37	17.24	
Judío	5.13	5.26	13.79	
Otros	10.26	2.63	13.80	
Ninguna	12.82	7.90	13.79	
Estado Civil:				.07
Soltero	27.5	45.0	74.1	
Casado	35.0	15.0	9.7	
Separado	12.5	10.0	9.7	
Divorciado	10.0	15.0	6.5	
Viudo	0.0	2.5	0.0	
Cohabitación	7.5	10.0	0.0	
Vuelto a casar	7.5	2.5	0.0	

parcialmente sobrepuesto. Para esto, la información obtenida de las evaluaciones psicométricas y el CFBQ, fue organizado en cuatro divisiones temáticas. Se aplicó a cada división un procedimiento de discriminación funcional de investigación "paso a paso". Tres divisiones temáticas presentaban variables del CFBQ que representaban las áreas de mayor contenido dentro de las cuales se esperaban hallar las diferencias básicas entre el grupo de adictos y los de control. Estas áreas eran: a) muerte y fallecimiento, b) separación y pérdida, c) religiosidad y filosofía de vida*. La cuarta división consistía en puntajes obtenidos de las evaluaciones psicométricas. Se incluyeron las covariantes de edad y educación ya que el grupo de adictos difería significativamente del grupo de estudiantes normales en edad y educación y de los pacientes psiquiátricos externos, en cuanto a edad.

Se indicó el procedimiento de investigación "paso a paso" eligiendo aquella variable de una determinada división que generara la diferencia grupal más significativa indexada por una razón F de un análisis directo de variación. La siguiente variable agregada era aquella que contribuía más a la distinción intergrupal independientemente de la contribución de la primera variable. Las variables agregadas en cada paso sucesivo eran aquellas que brindaban la mayor contribución a la distinción independientemente de la con-

tribución de la serie de variables incluidas en la función en el paso anterior. En cada paso se agregaba otra variable solamente si la significación de su contribución igualaba o excedía un nivel F especificado. Luego de cada agregado, aquellas variables que no igualaban o excedían el nivel especificado de significación eran suprimidas. A fin de llevar al máximo la información provista durante el procedimiento de investigación "paso a paso" referida al impacto contextual sobre las contribuciones a la distinción, el valor mínimo de las razones F requerido para agregar o retener una variable fue fijado en 1.00. Para esto hizo falta idear una regla de selección para escoger, de la secuencia de funciones generadas, aquella función que presentaba mayor número de discriminaciones que podrían considerarse estadísticamente confiables. Se emplearon los siguientes criterios: a) la función debe ser significativa con $p \leq .001$; b) cada regresor dentro de la función debe contribuir a la discriminación grupal en un nivel significativo del 5 por ciento o más; c) si es el último regresor en agregarse debe ser significativo en un nivel mayor al 10 por ciento y su inclusión debe incrementar la significación de un regresor incluido en un paso previo con $.10 \geq p > .05$ a $p \leq .05$. Como se detalla en el Cuadro II, el uso de estos criterios dió como resultado funciones cuyas contribuciones, más allá de las contribuciones de las covariables de edad y educación, presentaban una probabilidad de significación de .0007 ó menos. Un total de 29 de las 32 variables incluidas en las funciones escogidas contribuyen significativamente en un nivel del 5 por ciento ó más con "p" para las tres variables restantes entre los valores de .10 y .05.

* La lista completa de variable puede pedirse a los autores.

CUADRO II: Función discriminativa, comparación entre adictos y los grupos de control.^a

Series de variables	Adictos vs. Estudiantes				Adictos vs. Psiquiátricos			
	F	df	R ²	R	p	F	df	R
Muerte y fallecimiento	7.49	5.61	.38	.62	.00002	7.20	3.72	.48
Separación y pérdida	6.32	2.65	.16	.40	.00003	9.40	3.74	.53
Religiosidad y valores	6.99	4.62	.31	.56	.00003	5.13	5.72	.51
Batería psicométrica	9.09	4.64	.36	.60	.00007	6.14	3.71	.45

a: Los adictos reflejan la magnitud y significación de la discriminación entre grupos más allá de las diferencias en edad y educación.

RESULTADOS

Como se describe en el Cuadro II, las distinciones grupales entre los adictos y cada uno de los grupos de control, basadas en las variables de las cuatro divisiones temáticas no son solamente significativas sino que también tienen un tamaño apreciable. Las correlaciones múltiples (R) entre ser miembros de un grupo y los puntajes ponderados de las series de variables, referidas a la muerte, la separación, la religiosidad y el contenido de la batería psicométrica (principalmente sintomatología y estilo de vida familiar), oscilan entre los valores de .40 y .62. Por lo tanto entre el 16 por ciento y el 38 por ciento de la variación total, generada por las variables seleccionadas de cada división, se debe a las diferencias intergrupales. En cada caso, éstos valores reflejan diferencias grupales que persisten una vez eliminadas las diferencias de edad y educación.

Los Cuadros III y IV resumen diferencias univariadas y multivariadas entre el grupo de adictos y los grupos de comparación para las cuatro divisiones temáticas.

Muerte y Fallecimiento

El grupo de adictos y los grupos normales difieren en forma significativa ($p < .05$) al nivel univariado o multivariado en cuanto a 10 de las 33 variables de muerte y fallecimiento, y, en la undécima variable, la diferencia se acerca a tener significación ($p < .07$). Los drogadictos y los pacientes psiquiátricos externos difieren significativamente ($p < .05$) en 6 variables con tres variables adicionales que se acercan a tener significación ($.05 < p \leq .10$).

Surgieron una serie de rasgos sobresa-

lientes a partir de la evaluación de las diferencias univariadas y multivariadas entre el grupo de adictos y los dos grupos de control:

1) Los adictos difieren claramente de los estudiantes normales pero son comparables a los pacientes psiquiátricos en cuanto a la frecuencia de conducta y pensamiento suicida. Comparados con los estudiantes normales, los adictos han pensado, planeado e intentado suicidarse en mayor número de ocasiones. Por ejemplo, hubieron intentos de suicidio en 28 por ciento de los adictos, en 26 por ciento de los pacientes psiquiátricos externos, pero en ningún caso de los estudiantes normales. Al nivel multivariado, las diferencias entre adictos y estudiantes normales son representadas por la proporción de cada grupo que presenta por lo menos un intento de suicidio.

2) Durante la adolescencia los adictos tuvieron más experiencias de muerte de personas significativas que no miembros de la familia que los estudiantes normales y que los pacientes psiquiátricos externos. Esta diferencia es significativa a ambos niveles, tanto univariado como multivariado.

3) Los adictos difieren considerablemente de los pacientes psiquiátricos externos en cuanto a la vivencia de un mayor número de muertes de personas significativas. Comparando estos dos grupos, los adictos tienen un total de experiencias de muerte mayor; muertes de familiares durante la niñez, de una abuela, un abuelo o una mascota. Estas comparaciones univariadas significativas se ven representadas en el nivel multivariado por el número total de experiencias de muerte.

Al nivel univariado, los estudiantes

normales y los adictos no difieren significativamente en cuanto a estas experiencias de muerte. Sin embargo durante la adolescencia los adictos tuvieron más experiencias de muerte de un familiar directo que los estudiantes normales. Un mayor número de estudiantes normales tienen una figura paterna que perdió un padre durante su propia niñez que en los casos de los adictos. Al nivel multivariado, la frecuencia con que los estudiantes normales han sufrido la muerte de una abuela es de significación estadística elevada.

4) Se presentaron varias diferencias entre los adictos y los grupos de control en cuanto a su orientación hacia la muerte y el fallecimiento. Los adictos perciben que sus familias hablan sobre la muerte y el fallecimiento menos frecuentemente que los estudiantes normales o los pacientes psiquiátricos externos. A diferencia de éstos últimos, los adictos sienten que solamente unas pocas muertes cambiaron sus vidas drásticamente. Los adictos afirman reflexionar acerca de su propia muerte con menor frecuencia que los estudiantes normales. A pesar de que los adictos dicen haber llevado luto por algunos de sus difuntos, en un mayor grado al que llevaron los estudiantes normales, ambos afirman que sus hermanos llevaron luto en forma menos frecuente. Por lo tanto, es más común un medio familiar donde el impacto de muerte está minimizado o el tema de muerte es evitado entre los adictos que entre los grupos de control.

Separación y Pérdida

Entre las 19 variables referidas a la separación y pérdida, los adictos difieren signi-

CUADRO III. Muerte y Fallecimiento. Resumen de las Diferencias Grupales.

Variables	Promedios Grupales (Proporciones)				Comparaciones Grupales			
	Adictos a la Heroína (N = 39)		Estudiantes Normales (N = 30)		Adictos vs. Estudiantes		Adictos vs. Psiquiátricos	
	Ex. (N = 39)	Pacientes Psiquiátr. Ex. (N = 39)	Ex. (N = 30)	Pacientes Psiquiátr. Ex. (N = 39)	Univariado	Multivariado Parcial	Univariado	Multivariado Parcial
Total de muertes de personas significativas vividas por el individuo	3.26	2.67	1.82		t ^a	p ≤	t ^a	p ≤
Proporción del grupo que ha vivido:								
- Muerte de una persona significativa, no de la familia durante la adolescencia del individuo	(.38)	(.10)	(.07)		2.78	.007	.44	.001
- Muerte de un familiar directo durante la adolesc. del Ind.	(.28)	(.07)	(.21)		2.32	.025	3.42	.001
- Muerte de un miembro de la familia extensa durante la niñez del individuo	(.51)	(.67)	(.23)				2.66	.01
- Muerte de una abuela durante la niñez del individuo	(.28)	(.40)	(.10)		-1.02	NS	2.04	.05
- Muerte de un abuelo durante la niñez del individuo	(.23)	(.20)	(.08)				1.90	.06
- Muerte de una mascota	(.77)	(.77)	(.54)				2.18	.03
Grado en que el individuo ha pensado en su propia muerte	2.74	2.70	3.23				2.15	.04
							-31	.01

TERAPIA FAMILIAR

TERAPIA FAMILIAR

Grado en que el individuo ha pensado en suicidio	2.15	1.70	2.18	2.09	.04				
Grado en que el individuo ha planeado suicidio	2.05	1.40	1.82	2.50	.015				
Proporción del grupo que ha intentado suicidarse	(.28)	(.00)	(.26)	3.38	.001	.25	.05		
Número de intentos	.38	.00	.38	3.32	.002				
Proporción de muertes por las que el individuo sintió aficción en grado de moderado a considerado	(.57)	(.44)	(.49)	1.29	NS	.30	.02		
Proporción de muertes en los cuales los hermanos sintieron aficción en grado moderado a considerablemente	(.40)	(.51)	(.35)	-1.08	NS	-.38	.005		
Proporción de individ. cuyos padres han vivido la muerte de sus padres durante su propia niñez	(.08)	(.23)	(.13)	-1.85	.07				
Proporción de difuntos cuyas muertes hayan causado mucho cambio para el individuo	(.23)	(.20)	(.38)					-1.77	.08
Grado en que la familia del individuo ha hablado sobre la muerte y el fallecimiento	1.70	2.41	2.08	-3.32	.001			-1.85	.07

a Las t positivas indican que el promedio del grupo de adictos es mayor al número correspondiente de los grupos de control.

b Las r parciales son las correlaciones entre los puntajes de cada variable. Una r parcial positiva indica una variable cuya distribución causó el acercamiento de la función hacia el grupo de los adictos.

ficativamente ($p < .02$) de los normales en 3 variables y en un nivel del 7 por ciento de significación en una cuarta variable. Los adictos difieren significativamente de los pacientes psiquiátricos externos ($p < .04$) en 8 ítems, y con un nivel de significación entre el 5 y el 10 por ciento en 3 variables adicionales.

Una proporción mayor de adictos tuvieron experiencias de por lo menos una de las 8 categorías de separación en comparación con los 2 grupos de control, aunque no todas las diferencias son estadísticamente significativas. Una proporción mayor de adictos, comparados con los estudiantes normales, fueron separados de sus familias durante su niñez o adolescencia. Cuando se los compararon con los pacientes psiquiátricos externos, una proporción mayor de adictos tuvieron por lo menos una separación permanente. Durante la niñez así como durante la adolescencia, los adictos fueron más frecuentemente separados de sus familias, tuvieron algún tipo de separación temporal y un hermano que abandonaba el hogar inesperadamente. Además, fueron separados más frecuentemente de sus madres durante la niñez que los pacientes psiquiátricos externos y sus padres les dedicaban menos tiempo que en el caso de los estudiantes normales. Los adictos también afirman haber sufrido mayor impacto de separaciones temporarias que los pacientes psiquiátricos externos. La proporción de los casos del grupo de adictos para quienes por lo menos una persona se incorporó al grupo familiar (.88) es más del triple de los casos del grupo de pacientes psiquiátricos externos (.25). Finalmente el promedio de veces que los adictos abandonaron el hogar (3.40) es más del cuádruple que el promedio de

los estudiantes normales (.80) y más del triple del promedio de los pacientes psiquiátricos externos.

Solamente dos diferencias entre los adictos y los estudiantes normales, referidas a la separación, contribuyeron significativamente a una función distintiva incluyendo la edad y la educación: la cantidad de veces que el individuo abandonó el hogar, y el grado en que alguno de los padres estuvo fuera del hogar por razones sociales. En forma similar, tres variables contribuyeron significativamente a un incremento en la función comparando a los adictos con los pacientes psiquiátricos externos: la cantidad de veces que el individuo abandonó el hogar, la proporción del grupo que fue separado de su familia durante la niñez y la proporción del grupo para quienes por lo menos una persona se incorporó al grupo familiar.

Religiosidad y Valores

De un total de 28 variables sobre la religiosidad y los valores, 7 reflejan diferencias significativas ($p < .04$) al nivel univariado y multivariado entre los adictos y los estudiantes normales y una octava se aproxima a los valores de significación ($p < .10$). Los adictos y los pacientes psiquiátricos externos difieren en un nivel de significancia del 3 por ciento o más en cinco variables y en un 10 por ciento en dos variables adicionales.

El descubrimiento más importante de esta división temática es que los adictos, en comparación con los otros dos grupos de control, están menos interesados en la religión, es menos probable que le encuentren un sentido o propósito a la vida y que tengan valores altruísticos.

Comparando a los adictos con los estudiantes normales al nivel univariado, es menos probable que los primeros le encuentren un sentido definido a la vida, le dan menos importancia a contribuir con la sociedad, a trabajar por la erradicación de desigualdades sociales y económicas, y a incluir la religión en sus vidas actuales. Más aún, cuando los comparamos con los estudiantes normales, los adictos pocas veces afirman que existe algo en la vida por lo cual morirían atribuyéndole más importancia al hecho de "tener mucho dinero". En forma similar, diferencias univariadas significativas indican que los adictos, comparados con los pacientes psiquiátricos externos, le atribuyen menos importancia al hecho de ser líder en la comunidad, a trabajar para eliminar las desigualdades sociales y económicas y a tener buenas amistades. También afirman que la religión no jugó un rol importante durante su niñez. Los pacientes psiquiátricos externos dicen frecuentar más los servicios religiosos que los adictos.

En el nivel multivariado, las diferencias entre los adictos y los estudiantes normales aparecen en ítems que reflejan la presencia de un bien definido sentido central de la vida y la reconocida importancia que dan en trabajar para eliminar las desigualdades sociales y económicas. Cuando comparamos a los adictos con los pacientes psiquiátricos externos, las variables más relevantes son nuevamente la importancia de trabajar para eliminar las desigualdades sociales, junto con la importancia de la religión durante la niñez, la asistencia frecuente a servicios religiosos y la importancia de tener amistades profundas.

También hubieron variables que se incluyeron en ambas de estas funciones dis-

tintivas pero que no eran significativas a nivel univariado. A diferencia de los estudiantes normales, los adictos se inclinan con más vehemencia hacia "lo que nos ocurre luego de la muerte está relacionado con la manera en que vivimos nuestra vida sobre la tierra" y en asignarle una importancia mayor a un buen matrimonio y vida de familia. Comparados con los pacientes psiquiátricos externos, los adictos no comulgan ($p < .10$) con la idea de "diviértete en la tierra porque la muerte significa el fin de toda existencia".

Batería Psicométrica

Se incluyeron 16 variables en la división temática correspondiente a la batería psicométrica, de las cuales siete presentaron diferencias univariadas o multivariadas significativas ($p < .05$) entre adictos y normales. Otra variable adicional, tiene un nivel de significación multivariada del 10 por ciento. Sin embargo solamente dos variables revelan diferencias entre los adictos y los pacientes psiquiátricos externos, una en un nivel de significación del 5 por ciento y otra en el del 8 por ciento.

Las diferencias sintomatológicas grupales juegan un papel dominante al comparar los adictos con los estudiantes normales en un nivel univariado. Los adictos presentan niveles altos de sintomatología en los 5 ítems de la lista de los síntomas de Hopkins (HSCL); somatización, compulsivo-obsesivo, sensibilidad interpersonal, depresión y ansiedad. Además, en comparación con los estudiantes normales, los adictos obtienen puntajes significativamente más altos en la subescala de conflictos de la Escala de Medio Familiar

CUADRO IV: Variables de Separación y Pérdida. Resumen de las Diferencias Grupales.

Variables	Promedios Grupales (Proporciones)			Comparaciones Grupales			
	Adictos a la Heroína (N = 39)	Estudiantes Normales (N = 30)	Pacientes Psiquiátr. Ex (N = 39)	Adictos vs. Estudiantes		Adictos vs. Psiquiátricos	
				Univariado	Multivariado Parcial	Univariado	Multivariado Parcial
				t ^a	p ≤	t ^a	p ≤
Proporción del grupo que vivió por lo menos una separación permanente.	(.80)	(.47)	(.30)			2.20	.03
Proporción de grupos que fueron:							
- separados de sus familias durante la niñez	(.175)	(.03)	(.03)	1.91	.07	2.28	.02
- separados de sus familias durante la adolescencia	(.25)	(.03)	(.10)	2.60	.02	1.79	.08
- separados de sus madres durante la niñez	(.18)	(.07)	(.05)			1.78	.08
Proporción del grupo que tuvo al menos un:							
- hermanos que abandonó el hogar inesperadamente durante la niñez del individuo	(.10)	(.03)	(0.0)			2.08	.01
- hermanos que abandonó el hogar inesperadamente durante la adolescencia del individuo	(.15)	(.07)	(0.0)			2.08	.04
- separación temporaria durante su niñez	(.55)	(.30)	(.15)			3.24	.002
- separación temporaria durante su adolescencia	(.58)	(.46)	(.13)			3.57	.001

Número de veces que se abandonó el hogar	3.48	.80	1.10	3.52	.0008	.21	.09	3.57	.001	.40	.005
Veces que se incorporó una persona al grupo familiar	.88	1.27	.25					2.50	.002	.34	.005
Promedio en que un padre le dedicaba menos tiempo al indiv. por razones sociales durante su niñez	1.73	1.27	.174	3.01	.004	.33	.008				
Intensidad promedio del impacto emocional de separaciones temporarias	1.58	1.50	.91					1.92	.06		

a Las t positivas indican que el promedio del grupo de adictos es mayor al número correspondiente de los grupos de control.
b Las r parciales son las correlaciones entre los puntajes de cada variable. Una r parcial positiva indica una variable cuya contribución causó el acercamiento de la función hacia el grupo de los adictos.

(FES) y puntajes más bajos en la escala del Propósito en la Vida.

El análisis de los resultados de las comparaciones de los adictos vs. los pacientes psiquiátricos externos nos muestra que ambos grupos obtuvieron puntajes elevados en tres de los ítems del HSCL, mientras que el puntaje de los adictos era un tanto más elevado en el ítem de somatización ($p < .09$) y el de los pacientes psiquiátricos externos era más elevado en el ítem de ansiedad ($p < .05$). Es también notorio que tanto los pacientes psiquiátricos externos como los adictos, a diferencia de los estudiantes normales, presentan puntajes altos en la subescala de conflictos del FES y puntajes bajos en la escala del propósito en la vida.

Los resultados de las funciones distintivas confirman los descubrimientos referidos al nivel de desorden psíquico, pero a su vez, también revelan los efectos contextuales en los cuales están incluidos la sintomatología, las percepciones acerca del estilo de vida familiar, y el análisis del propósito de la vida. El puntaje promedio relativamente alto de los adictos para el ítem de somatización llevó a incluir esta variable como un factor significativo para distinguir claramente las funciones que comparaban a los adictos con los estudiantes normales y los pacientes psiquiátricos externos.

Los Padres

Los supuestos teóricos de esta investigación se basan en el concepto que hay un modelo intergeneracional repetitivo de conducta humana. Para iniciar una exploración inicial de este tema se tomó un

CUADRO V: Religiosidad y Valores. Resumen de las Diferencias Grupales.

Variables	Promedios Grupales (Proporciones)				Comparaciones Grupales			
	Adictos a la Heroína (N = 39)		Estudiantes Normales (N = 30)		Adictos vs. Estudiantes		Adictos vs. Psiquiátricos	
					Univariado	Multivariado Parcial	Univariado	Multivariado Parcial
			Ex. (N = 30)	Pacientes Psiquiátr. (N = 30)	t ^a	p	t ^a	p
Grado en que está presente un bien definido sentido de la vida ^c	2.75	3.52	2.73	3.48	.001	.38	.005	
Reconocida importancia de tener un buen matrimonio y vida de familia ^c	3.70	3.59	3.68	.71	NS	.27	.05	
Reconocida importancia al tener mucho dinero ^c	3.33	2.86	3.10	2.51	.02			
Reconocida importancia de amistades profundas ^c	3.45	3.66	3.80					
Reconocida importancia de contribuir con la sociedad ^c	3.05	3.48	3.20	-2.21	.04		-2.51	.02
Reconocida importancia de ser líder en la comunidad ^c	2.40	2.55	2.83					.025
Reconocida importancia de darle a los hijos "mejores oportunidades de las que tuvo yo" ^c	3.98	3.93	3.70				-2.34	.03
Reconocida importancia al trabajar para eliminar las desigualdades sociales y económ. ^c	2.58	3.17	3.10	-2.47	.02	-.27	2.25	.03
Grado de acuerdo con "lo que nos ocurre luego de morir se relaciona con la manera en que vivimos la vida terrenal" ^d	2.88	2.55	3.10	1.08	NS	.26		.05

Variables	Promedios Grupales (Proporciones)				Comparaciones Grupales			
	Adictos a la Heroína (N = 39)		Estudiantes Normales (N = 30)		Adictos vs. Estudiantes		Adictos vs. Psiquiátricos	
					Univariado	Multivariado Parcial	Univariado	Multivariado Parcial
			Ex. (N = 30)	Pacientes Psiquiátr. (N = 30)	t ^a	p	t ^a	p
Grado de acuerdo con "diviértete en la tierra ya que la muerte es el fin de toda existencia" ^d	1.65	1.48	1.80				-.62	NS
Importancia de la religión en sus vidas actualmente ^c	2.55	3.21	2.98	-2.74	.008			
Importancia de la religión durante su niñez ^c	3.40	3.21	3.03				1.74	.09
Frecuencia de asistencia a servicios religiosos ^c	1.83	2.17	2.35				-2.25	.03
Proporción de individuos que morirían por algo.	(.20)	(.41)	(.32)	-1.72	.10		-.32	.005

a Las t positivas indican que el promedio del grupo de adictos es mayor al número correspondiente de los grupos de control.

b Las r parciales son las correlaciones entre los puntajes de cada variable. Una r parcial positiva indica una variable cuya contribución causó el acercamiento de la función hacia el grupo de los adictos.

c 1: nada/ninguna; 2: mínima; 3: moderadamente; 4: mucho.

d 1: total desacuerdo; 2: moderado desacuerdo; 3: moderado acuerdo; 4: acuerdo total.

subgrupo de padres (N = 69)* de cada uno de los tres grupos y se los sometió a la misma batería de pruebas que fue administrada individualmente a sus hijos**.

Los resultados preliminares revelaron que los padres del grupo de los adictos a la heroína tuvieron el mayor número de pérdidas debidas a muertes inusuales o separaciones de figuras importantes. Por ejemplo, como se ve en el Cuadro VII, comparados con los otros dos grupos, el grupo de padres de los adictos a la heroína vivieron más muertes de familiares que vivían con ellos en el momento del fallecimiento. Para el grupo de padres de los adictos, la mayor proporción de muertes era de parientes menores de 20 años (18 por ciento) a diferencia de la proporción para los padres de los estudiantes normales (9 por ciento) y para los padres de los pacientes psiquiátricos externos (6 por ciento). Estas muertes generalmente ocurrieron durante la niñez de los padres. Resulta de especial interés el hecho de que un gran número de los padres del grupo de los adictos hayan perdido parientes en accidentes, asesinatos, suicidios y muerte blanca. Pocos fueron los casos en que

* Estos datos están basados en una muestra de 69 individuos incluyendo a 24 padres (madres y padres) de adictos a la heroína, 24 padres de pacientes psiquiátricos externos y 21 padres de estudiantes secundarios normales. En algunos casos se obtuvieron los datos de las madres solamente y en pocos casos de una dicotomía de madres y padres. Debido a los límites en cuanto al tamaño de la muestra los resultados iniciales fueron obtenidos de estadísticas descriptivas.

** El material presentado en esta sección se refiere a tres de los grupos de padres de la investigación. El cuarto grupo, compuesto por los padres de los estudiantes "tensionados", será analizado en una fase posterior del estudio.

los padres de los pacientes psiquiátricos externos vivieron la muerte de un familiar por causas o circunstancias excepcionales y los padres de los estudiantes normales no tuvieron tales experiencias. En cuanto a la separación, ninguno de los padres de los estudiantes normales había sido separado de su madre natural o adoptiva durante su niñez o adolescencia. Por el contrario, tanto los padres de los pacientes psiquiátricos externos como los de los adictos sí habían tenido tales experiencias. A diferencia de los otros grupos los padres de los estudiantes normales nunca fueron separados de sus familias o llevadas a vivir con otros parientes durante su niñez. Diferencias grupales adicionales se obtienen para otro tipo de desorden como ser la separación temporal de su familia o cambio en la estructura interna del hogar ya sea por la llegada o partida de otras personas al grupo familiar. Una vez más esto ocurre frecuentemente entre los padres de los adictos a la heroína. Probablemente lo más interesante sea que los padres de los adictos, a diferencia de los otros dos grupos, en general abandonaron sus hogares a una más temprana edad, pero también eran más capaces de regresar a sus hogares, un modelo característico que tanto domina entre los adictos a la heroína.

Las diferencias grupales de religiosidad se asocian más a menudo con los valores y las actitudes que con la práctica religiosa misma. Entre los padres de los adictos prepondera la creencia de que "lo que ocurra después de la muerte está relacionado con la manera en que viven la vida en la tierra", mientras que los padres de los otros dos grupos no comparten esta creencia. En forma semejante, los padres de los pacientes psiquiátricos externos y

de los estudiantes normales están dispuestos a ofrecer sus vidas por alguien mientras que los padres de los adictos no harían tal cosa. Los padres de los pacientes psiquiátricos externos afirman temerle mucho a la muerte y al morir, mientras que los padres de los estudiantes normales expresaron un menor temor.

El éxito es valorado más por los padres de los adictos y por los de los estudiantes normales que por los padres de los pacientes psiquiátricos externos. Como es de esperar, el tener un claro y definido propósito en la vida es más común entre los padres de los normales que en los de los otros dos grupos.

En la Escala del Medio Familiar (FES), los padres de los adictos obtuvieron un puntaje más alto en Cohesión que los padres de los pacientes psiquiátricos externos, quienes obtuvieron el puntaje más bajo. En expresividad los padres de pacientes psiquiátricos externos obtuvieron las más altas y los padres de adictos las más bajas. La subescala de Independencia indica que los padres de los adictos obtienen el puntaje más elevado y los padres de los pacientes psiquiátricos el más bajo. En la subescala que mide características Intelectuales/Culturales, los padres de los estudiantes normales obtuvieron el mejor puntaje y los padres de los pacientes psiquiátricos externos el peor. El puntaje para Depresión es más elevado en el caso de los padres de los adictos y pacientes psiquiátricos externos y más bajo para los padres de los estudiantes normales.

DISCUSION

Estos descubrimientos apoyan los concep-

CUADRO VI: Variables de la Batería de Pruebas Psicométricas. Resumen de las Diferencias Grupales.

Variables	Comparaciones Grupales									
	Promedios Grupales (Proporciones)					Adictos vs. Estudiantes				
	Adictos a la Heroína (N = 39)		Estudiantes Normales (N = 30)		Pacientes Psiquiátricos Ex. (N = 39)		Univariado		Multivariado Parcial	
							t ^a	p	r ^b	p
Lista de síntomas de Hopkins:										
Somatización	1.78	1.30	1.57	5.08	.0001	.48	.001	1.78	.08	.30
Obsesivo-compulsivo	1.82	1.55	1.80	2.06	.05	.28	.025			
Sensibilidad interpersonal	2.00	1.63	2.08	2.76	.008					
Depresión	1.99	1.54	2.05	3.93	.0003					
Ansiedad	1.65	1.41	1.94	2.10	.04			2.04	.05	.35
Escala del medio familiar:										
Conflicto	49.15	42.61	46.19	2.32	.03					
Activo-recreacional	44.55	46.58	39.89	.51	NS	.23	.10	1.31	NS	.24
Propósito en la vida	96.10	110.50	93.70	3.42	.0003	.33			.05	

tos teóricos más importantes del estudio. La incidencia de la muerte varía sorprendentemente entre los grupos y difiere significativamente para los adictos, cuyo ciclo de vida familiar muestra una clara orientación hacia la muerte, están vinculados con el suicidio o ideas suicidas y han tenido experiencias de muerte que son frecuentemente prematuras y de naturaleza poco común, todo lo cual parece ocurrir a lo largo de dos generaciones. En total, los adictos tienen más separaciones permanentes de sus familias, y como grupo tienden a desarrollar un modelo específico, repetitivo e intergeneracional de alejamiento y retorno a sus familias. Finalmente, el concepto de religión es muy distinto para los adictos, al no haber un claro y definido sentido o propósito en la vida en ambas generaciones.

Tal vez lo más interesante sea la ubicación de los descubrimientos en un marco evolutivo del ciclo de vida familiar, especialmente cuando se incluyen algunos de los resultados cualitativos. Existe una mayor tendencia entre los adictos a haber tenido una separación prolongada de sus familias, o de su madre o madre sustituta durante la niñez. También durante la niñez es más probable que un adicto haya tenido un hermano que abandonó el hogar por razones no asociadas a los cambios normales, por ejemplo: encarcelación o fuga. Aún las separaciones temporarias ocurren en más de un 50 por ciento de la población adicta. Entre todos estos desórdenes, es probable encontrar también la muerte de algunos de los abuelos. Por lo tanto la niñez de un adicto presenta un fuerte elemento de pérdida y separación.

Consecuencias inmediatas de estas experiencias se reflejan en el trabajo de

Bowlby, quien recientemente³ reafirmó sus clásicos descubrimientos referidos a que la pérdida sin resolución durante la niñez temprana produce modelos alterados de conducta de apego, conduciendo eventualmente a una tensión crónica y a una depresión severa. Eisenstadt¹⁶ también considera la pérdida temprana como detonante de una crisis que requiere dominio o "duelo creativo", sin los cuales puede resultar una conducta antisocial. Eisenstadt ve a la unidad familiar como la principal variable interviniente. Por lo tanto es más significativo el contexto en el cual ocurre la crisis que el hecho traumático en sí.

Una vez más, para los adictos hay más separaciones de la familia total durante la adolescencia. Como en el período previo del desarrollo, puede sumarse a todo esto el abandono inesperado del hogar de un hermano. Cuando se tiene en cuenta que es más frecuente que un adicto viva tanto la muerte de un familiar directo, en esta etapa, como la de una persona significativa que no pertenece al grupo familiar, el período de la adolescencia resulta ser altamente desgarrador y traumático.

Uno de los factores contextuales pertinentes es que el adicto es más proclive a tener padres que hayan perdido un miembro familiar que convivía con ellos durante su niñez. Estas experiencias de muerte bien pueden infundir a los padres una elevada ansiedad en cuanto a cualquier tipo de pérdida dentro de sus familias de procreación. Por lo tanto cuando un hijo se prepara para dejar su hogar, aún a una edad apropiada, este hecho normal en el ciclo de la vida se llena de conflictos y ambivalencia. Esto podría explicar el modelo repetitivo de abandonar el hogar y

CUADRO VII: Muertes de miembros de las familias de los padres de los grupos comparativos

Variables	Adictos (N = 24)		Pacientes Psiquiátricos Externos (N = 24)		Estudiantes (N = 21)	
	Total	Promedio	Total	Promedio	Total	Promedio
Muertes de miembros de la familia	125	5.21	104	4.33	81	3.86
Miembros de la familia que fallecieron mientras vivían con los individuos:						
— antes de los 21 años de los individuos	17	.71	16	.67	8	.38
— antes de la adolescencia de los individuos	14	.58	4	.17	3	.14
Miembros de la familia directa y extensa que fallecieron antes de los 21 años de los individuos	21	.88	16	.67	9	.43

regresar a él, un modelo que es tan diferente al de cualquiera de los otros dos grupos. Esta conducta particular sugiere que el adicto no es una "persona callejera" como se lo describe con tanta frecuencia, sino que está muy ligado a la familia y al hogar, a pesar de que este vínculo esté tan asociado a una ansiedad excesiva. Estos descubrimientos apoyan muchos de los datos clínicos reseñados por Stanton.²⁷

Otro factor contextual es la resistencia de la familia del adicto a hablar sobre la muerte y el morir, una función comunicativa familiar que generalmente está asociada con familias psicológicamente saludables.²⁰ Tal vez la incapacidad de la familia del adicto para afrontar directamente las connotaciones humanas de la muerte está conectada con el medio conflictivo en que viven, un hecho respaldado por descubrimientos de la Escala del Medio Familiar de Moos. Cuando se une la falta de compromiso formal religioso del adicto con su falta generalizada de propósito en la vida, el medio familiar parecería ser frío y triste.

Los sistemas de valores difieren considerablemente para el grupo de los adictos. Tanto los adictos como sus padres creen que "lo que nos ocurra cuando fallecemos está relacionado con la manera en que vivimos nuestra vida en la tierra". Ambas generaciones están menos dispuestas a morir por alguien que los individuos de los otros dos grupos o sus padres. Esto tal vez refleje el grado moderado de ansiedad de los padres de los adictos ante la muerte y el morir. También puede estar relacionado con la falta de sentido o propósito en sus vidas ya que seguramente el entregar la propia vida por una razón jus-

tificable es indicativo de algún tipo de propósito.

Los adictos parecen tener un sistema de valores relativamente concreto. Le dan mucha importancia al dinero pero no se preocupan por los valores más abstractos asociados con el contribuir a la sociedad, el ser un líder social o el solucionar las desigualdades sociales y económicas, valores que están más frecuentemente asociados con los estudiantes normales. Es interesante notar, sin embargo, que el adicto le da más importancia que los otros dos grupos al tener un buen matrimonio y vida familiar, y quiere darle a sus hijos mejores oportunidades de las que tuvo él. Uno tal vez especularía que esto último está relacionado con sus propios vínculos con la familia de origen. Esto caracteriza a su conflicto central de tipo adolescente. No están aún preparados para cumplir con los objetivos y los valores de la sociedad ya que aún están ensimismados con su crecimiento y el dejar el hogar. Por lo tanto los adictos se aferran a la familia aún cuando están ordenando sus valores y actitudes jerárquicamente. Aún no están preparados para ir más allá del sistema familiar para abarcar el sistema mayor.

Esta preocupación por sí mismos es tal vez más obvia en el grado de interés por su cuerpo del adicto. Sus altos puntajes en somatización sugieren un foco muy fuerte en su cuerpo, un hecho ciertamente comprensible teniendo en cuenta su adicción a la heroína. Paradójicamente, estos individuos se ven compelidos compulsivamente a inyectarse una droga potente en las venas y luego se preocupan obsesivamente de los mismos cuerpos que maltratan continuamente.

RESUMEN E INFERENCIAS

Esta investigación acerca de los principales factores contextuales en la vida familiar de tres grupos especiales señala un particular modelo ideomórfico de vida familiar asociado con los adictos a la heroína, y apoya las diversas observaciones clínicas en cuanto a que las vidas y las familias de un adicto son verdaderamente diferentes. A pesar de que es imposible describir todas las diferencias, queda claro que algunos factores familiares importantes discriminan entre los adictos y los otros dos grupos de comparación. Utilizando un modelo de investigación que incorpora la teoría de los sistemas familiares, emerge un paradigma evolutivo del ciclo de la vida que refleja un singular continuo de experiencias que parece mantenerse a lo largo de las generaciones, acreditando la teoría de transmisión intergeneracional de conducta.

Además, se pueden integrar al paradigma familiar teorías más tradicionales de la psicología del desarrollo. Por ejemplo, las morales concretas, las actitudes y los valores de los adictos a la heroína reflejan la teoría Piagetiana²³ y sugieren que el adicto no ha alcanzado aún el estadio operativo formal del desarrollo cognitivo. Eso es coherente con la incapacidad emocional del adicto para crecer y dejar el hogar.

Otra complicación importante de estos descubrimientos es que el abordaje familiar al tratamiento o a la prevención de la adicción a la heroína es un método viable de intervención. Dos de los autores (SBC y JDK) están actualmente escribiendo un libro para padres¹⁰ centrado en hacer frente a las pérdidas para preve-

nir las consecuencias nocivas de largo alcance de tales traumas no resueltos.

Más específicamente, terapeutas familiares pueden usar los descubrimientos de esta investigación como fundamento organizativo al trabajar con familias con problemas de abuso de drogas. Por ejemplo, en la etapa inicial del tratamiento es importante explorar las experiencias del ciclo de vida familiar intergeneracional de muerte, pérdida y separación. Además se debería indagar acerca de los valores religiosos familiares y su orientación hacia el sentido y propósito en la vida. Al aparecer estos factores críticos, el terapeuta observa el contexto estructural y las transacciones que rodean el uso de drogas del miembro familiar. Una vez obtenida esta información, se pueden planear intervenciones en el tratamiento para incorporar información obtenida en sesiones anteriores. Por ejemplo, intervenciones específicas descritas por Coleman y Stanton¹² utilizan experiencias más tempranas de muerte y pérdida en un abordaje del "aquí y ahora" para el cambio.

En resumen, esta investigación ha tomado un abordaje bastante poco usual. Hemos intentado ingresar a las familias de estos individuos observando los modelos familiares, determinando quién estaba presente en el momento del nacimiento, cuándo partieron y las circunstancias que rodearon su partida. Estudiamos cada experiencia de muerte, conociendo la causa y circunstancias así como también los efectos concomitantes y subsecuentes sobre el individuo y los demás miembros familiares. Indagamos en muchas áreas de la vida familiar —en busca de matices que sirvieran para diferenciar a nuestro gru-

pos. Estos descubrimientos derivan, por supuesto, de investigaciones retrospectivas y están limitados metodológicamente debido a los factores del tiempo transcurrido y déficit de memoria. Además, debido a que dependen de evocaciones perceptuales, estos datos están claramente sujetos a todas las distorsiones relacionadas con la información retrospectiva. Por lo tanto los descubrimientos que se presentan aquí deben ser tomados como una base inicial de datos para comprender los modelos complejos pero intrigantes de la vida familiar.

Claramente, un estudio prospectivo ofrecería un método importante para verificar y aumentar los descubrimientos presentados en este artículo. El valor de este estudio se halla, sin embargo, en el apoyo que le brinda a la teoría, lamentablemente incompleta, del duelo en el abuso de drogas⁶⁻⁷ que enfoca a la drogadicción como un mecanismo complejo con el que la familia hace frente a experiencias de vida repetitivas que son demasiado perniciosas para enfrentar con sobria aceptación. En la presente etapa de construcción teórica, los conocimientos adquiridos de este estudio prestan fe a los principales principios teóricos.

Se siguen formulando preguntas y persiste una paradoja dejándonos con un dilema del tipo "huevo y gallina". Aún no estamos seguros si las estructuras familiares son consecuencia del abuso de drogas o si la conducta de aquél que toma drogas es el resultado de la configuración estructural familiar. No obstante, estos datos proveen evidencia de que el ciclo de vida familiar de un adicto a la heroína difiere significativamente de las historias familiares del de los grupos de control. Por lo tanto, de manera circular y reflexi-

va, aquellos que experimentan las vicisitudes del abuso de heroína parecen cumplir con un legado familiar vinculado con pérdidas pero al que le faltan los apuntes que podrían proveer el alivio recuperativo esencial para el desarrollo y la estabilidad emocional.

RESUMEN

Esta es una investigación sobre la función de la adicción a la heroína como un método adquirido a nivel familiar para sobrellevar la separación, pérdida, y muerte a lo largo del ciclo de la vida. Para esto se entrevistaron adictos a la heroína, pacientes psiquiátricos externos y estudiantes normales los cuales fueron sometidos a una batería de pruebas para determinar la incidencia de la pérdida de algún miembro familiar u otra persona cercana. El impacto de la muerte generalmente se vence a través de rituales religiosos y por lo tanto se investigaron los valores religiosos y las ideas acerca del sentido y el propósito de la vida de las familias de estos individuos. Los resultados indican que la incidencia de la muerte difiere significativamente entre los grupos y que los adictos presentan una orientación distinta hacia la muerte, más suicida, y tienen experiencias relacionadas con la muerte más prematuras y bizarras. Generalmente son personas que durante su infancia sufren más separaciones familiares, lo que los lleva a desarrollar un modelo específico de continua separación, y regreso a sus familias. Es poco probable que tengan un claro y definido propósito en la vida. Cuando se realizó la entrevista y la batería de pruebas en un subgrupo de padres de cada grupo, los resultados apoyaron la teoría

de la transmisión intergeneracional de conducta.

Fam Proc. 25: p. 2-23, 1986.

SUMMARY

This research studied the function of heroin addiction as a family-learned method of coping with death, separation, and loss across the life cycle. Heroin addicts, psychiatric outpatients, and normal students were given an extensive interview and test battery to determine the incidence of loss of family members and significant others. Because the impact of death is often overcome through religious rituals, this study also investigated the subjects' perception of their families' religious values and orientation to life's meaning and purpose. Results indicate that the incidence of death differs significantly across groups and that addicts have a distinct orientation to death, are more suicidal, and have more premature and bizarre death experiences. During childhood they have more family separations, and they tend to develop a distinct pattern of continuously separating from and returning to their families. They are also less likely to have a clearly defined purpose in life. A subset of parents from each group were also interviewed and tested, and these results support the theory of the intergenerational transmission of behavior.

BIBLIOGRAFIA

1. AMMONS, R.B. and AMMONS, C.H., The Quick Test (QT): Provisional Manual, *Psychological Reports*, Monograph Supplement I-VIII) 11:111-161, 1962.

2. BLUM, R. and Associates. *Horatio Alger's Children*, London; Jossey-Bass, 1972.
3. BOWLBY, J., *Attachment and Loss*, vol. 3, New York, Basic Books, 1980.
4. CARTER, E. and MCGOLDRICK, M. (eds.) *The Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy*, New York, Gardner Press, 1980.
5. COLEMAN, S.B., "Death - The Facilitator of Family Integration", Paper presented at the American Psychological Association's Annual Meeting, Chicago, September, 1975.
6. —, "Incomplete Mourning and Addict Family Transactions: A Theory for Understanding Heroin Abuse", in D. Lettieri (ed.), *Theories of Drug Abuse*, National Institute on Drug Abuse, Research Monograph 30, DHHS Pub. No (ADM) 80-967, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1980.
7. —, "Incomplete Mourning in Substance-Abusing Families: Theory, Research and Practice", in L.R. Wolberg and M.L. Aronson (eds.), *Group and Family Therapy*, 1981, New York, Brunner/Mazel, 1981.
8. —, "Therapists' Perceptions of "Best" and "Worst" Period of Heroin Addict Development", Unpublished manuscript, 1982.
9. COLEMAN, S.B. and KAPLAN, J.D., "A Pilot Investigation of Relative Frequencies of Death and Drug Usage Within the Families of Drug-Abusing and Non-Drug-Abusing Populations", Unpublished manuscript, 1980.
10. —, *From Pins to Needles: A Parents' Handbook on Preventing Drug Abuse*, Manuscript in preparation.
11. COLEMAN S.B., KAPLAN, J.D. GALLAGHER, P.R., DOWNING, R.W., and CAINE, C., *Heroin - A Family Coping Strategy for Death and Loss: Final Report 1979-1981*, National Institute on Drug Abuse, Grant No R01-DA-02332-02, Achievement Through Counseling and Treatment, Washington, D.C., April, 1982.
12. COLEMAN, S.B. and STANTON, M.D., "The Role of Death in the Addict Family", *J. Marr. Fam. Counsel.* 4: 79-91, 1978.
13. CRUMBAUGH, J.C. and MAHOLICK, L. T., "An Experimental Study in Existentialism: The Psychometric Approach to Frankl's Concept of 'Noogenic Neurosis'", *J. Clin. Psychol.* 20: 200-207, 1964.
14. DEROGATIS, L.R., LIPMAN, R.S., RICKELS, K., UHLENHUTH, E.H., and CO-

- VI, L., "The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A Self-Report Symptom Inventory", *Behav. Sci.* 19: 1-15, 1974.
15. DIGGORY, J.C. and ROTHMAN, D.Z., "Values Destroyed by Death", *J. Adnorm. Sci. Psychol.* 63: 205-210, 1961.
 16. EISENSTADT, J.M., "Parental Loos and Genius", *Am. Psychol.* 33: 211-223, 1978.
 17. ERICKSON, E., *Infancia y Sociedad*, Ed. Harmé, 1959.
 18. GERTLER, R., FERNEAU, E., and RAYNES, A., "Attitudes Toward Death and Dying on a Drug Addiction Unit", *Int. J. Addictions*, 8: 265-272, 1973.
 19. LESTER, D., "The Construction of a Fear of Death Scale: Its Consistency, Validity and Use", Unpublished manuscript, Brandeis University, 1966.
 20. LEWIS, J.M., BEAVERS, W.R., GOSSETT, J.T., and PHILLIPS, V.A., *No single Thread: Psychological Health in Family Systems*, New York, Brunner/Mazel, 1976.
 21. MILLER, D., *Adolescence, Psychology, Psychopathology and Psychotherapy*, New York, Jason Aronson, 1974.
 22. MOOS, R.H., *The Social Climate Scales: An Overview*, Palo Alto, Calif. Consulting Psychologists Press, 1974.
 23. PIAGET, J., and INHELDER, B., *The Growth of Logical Reasoning: Childhood to Adolescence*, New York, Basic Books, 1958.
 24. REILLY, D.M., Family Factors in the Etiology and Treatment of Youthful Drug Abuse, *Fam. Ther.* 2: 149-171, 1976.
 25. STANTON, M.D., "The Addict as Saviour: Heroin, Death and the Family", *Fam. Proc.* 16: 191-197, 1977.
 26. STANTON, M.D., "A Family Therapy of Drug Abuse", in D. Lettieri (ed.), op. cit.
 27. —, *Family Therapy of Drug Abuse and Addiction*, New York, Guilford Press, 1982.
 28. STANTON, M.D. and COLEMAN S.B., "The Participatory Aspects of Indirect Self-Destructive Behaviour: The Addict Family as a Model", in N. Farberow and D. Lettieri (eds.), *The Many Faces of Suicide*, New York, McGraw-Hill, 1980.
 29. STANTON, M.D., TODD, T.C., HEARD, D.B., KIRSCHNER, S., KLEIMAN, J.I., MOWATT, D.T., RILEY, P., SCOTT, S.M., and VAN DEUSEN, J.M., "Heroin Addiction as a Family Phenomenon: A New Conceptual Model", *Am. J. Drug Alc. Abuse*, 5: 125-150, 1978.
 30. WHIPPLE, C., "Meaning of Death in Drug Users", Paper presented at the Midwestern Psychological Association, Chicago, May, 1973.

Comentario al artículo:

CICLO DE VIDA Y ABANDONO

De S.B. Coleman, J.D. Kaplan y R.W. Downing

Dr. JUAN CARLOS NOCETTI

Licenciado en Psicología. Psicoanalista. Terapeuta Familiar.

Las investigaciones acerca de las relaciones existentes entre ciertas características de uno o ambos padres y determinados trastornos mentales de algún hijo, habían

llegado —hacia la década del cincuenta—, a un desenlace poco optimista: "En conjunto la revisión de los 'estudios de rasgos', produce la impresión de que ninguno de los rasgos parentales seleccionados para la investigación se puede correlacionar en forma clara y predecible con un resultado patológico determinado y que, si bien pueden constituir una condición necesaria para la aparición de un tipo específico de desorden psicológico en el niño, sin duda no constituye una condición suficiente" (Verón, 1968).

El cambio epistemológico que trajo aparejada la necesidad de encarar el estudio y el tratamiento de familias, abrió

nuevas perspectivas para la continuidad de estas investigaciones. La complejidad de los sistemas a investigar no se eludía por medio del análisis de sus componentes: tal complejidad constituía una propiedad esencial que el análisis sólo lograba destruir. Se hizo imprescindible elaborar nuevas estrategias de investigación.

Una de estas estrategias (propuesta por Verón en 1968), consistía en la comparación de *configuraciones de variables de distinto nivel*, en lugar del prolijo análisis de un reducido número de factores, con la condición de que los núcleos invariantes que permitieran establecer diferencias significativas se buscasen más en un plano *formal* que en el contenido cultural o psicológico de cada tipo de trastorno.

Si mi evaluación del trabajo que hemos leído es correcta, nos encontramos frente a un serio intento de llevar adelante un programa semejante.

Se han comparado configuraciones de factores agrupado en cuatro áreas: "orientación hacia la muerte", "abandono", "valores religiosos y filosóficos" y evaluaciones psicométricas. Las correlaciones significativas encontradas al comparar estas configuraciones apuntan justamente a señalar el carácter interrelacionado de los factores en juego. Y ello no sólo en cuanto al contenido psicológico o cultural de las variables examinadas, sino en cuanto a demostrar la existencia de un modelo repetitivo particular para encarar los acontecimientos ocurridos en los ciclos de vida familiar. Se está pensando así —a mi modo de ver—, a niveles formales de determinación de las conductas observadas.

Y esto por dos razones. En primer lugar, no se trata de una relación simple y directa entre experiencia vivida y tipo de conducta (aun cuando así se lo enuncie

en algunos párrafos como ya veremos), sino que se remite a modelos de organización de esas experiencias, lo cual compromete un nivel lógico superior que sobrepasa la posibilidad de conciencia de los sujetos implicados.

En segundo lugar, porque se trata además de poner en descubierto el contexto del contexto por el cual la experiencia adquiere su eficacia. De este modo, por ejemplo, las experiencias tempranas de muerte en adictos, corresponde al nivel de estímulo elemental, sin embargo, ellas ocurren en un contexto en el cual se introduce una elevada ansiedad ante las pérdidas, sin el cual su poder de eficacia podría minimizarse: es éste el contexto que corresponde a los modelos e incluye marcadores de contexto. Por último, existen valores religiosos y filosóficos que organizan el contexto de ese contexto: un meta-metamensaje que clasifica el metamensaje del contexto que clasifica la experiencia elemental (Bateson, 1976).

Este tercer nivel contiene condiciones para tipos de Aprendizaje II, en el cual es posible la producción de cambios en el uso de los marcadores de contexto. En la medida que ello data de la primera infancia y es inconsciente, resulta coherente la sugerencia de los autores: "indagar acerca de los valores religiosos y su orientación hacia el sentido y propósito de la vida" como base de intervenciones "en un abordaje del aquí y ahora para el cambio".

Esta investigación refuerza además en sus conclusiones la necesidad señalada por Bateson en el sentido de sostener la suposición del contexto repetible. Es justamente la inclusión de los factores contextuales, la que permite avalar esta su-

posición y constatar la existencia de un modelo intergeneracional repetitivo. Esas mismas conclusiones sugieren además que debiéramos pensar que lo repetitivo son los modelos y no necesariamente las conductas (ya que los padres de los adictos no presentan tal conducta adictiva), cosa que —dicho sea al pasar—, he sostenido en otros trabajos (Nocetti, 1983 a y b).

La comparación de los valores obtenidos a partir de las configuraciones de factores entre ambas generaciones y entre los diferentes grupos, establece una semejanza significativa en el primer caso y un poder discriminativo en el segundo. Es decir, esos valores permiten diferenciar con respecto a los grupos de control, no sólo a los adictos sino también a sus padres. Se afirma de esta manera la posibilidad de sostener la existencia de un modelo particular de vida familiar.

Hasta aquí los méritos que he podido encontrar en la investigación que nos ocupa. He tratado de ceñirme para tal evaluación a los límites que definen los modelos epistemológicos y las teorías básicas en las cuales los investigadores expresamente se han apoyado.

Con el mismo espíritu quisiera ahora reflexionar acerca de algunas cuestiones planteadas en esta investigación. Se trata sin lugar a dudas —y los mismos autores se preocupan de señalarlo—, de una investigación pionera en su metodología. Parece por lo tanto pertinente discutir algunos puntos en vista a un estudio venidero de los mismos autores.

Me parece que algunas afirmaciones propuestas no resultan coherentes con las ideas básicas que han guiado esta investigación. Creo importante destacarlo porque oscurecen otras afirmaciones más en-

riquecedoras, remiten a modos de pensamiento compatibles con una forma de conductismo que hoy —y sobre todo a partir de G.H. Mead—, consideraríamos excesivamente mecanicistas (e incompatibles por lo tanto con una “teoría de los sistemas familiares”), y son el parte responsables del dilema tipo “huevo y gallina” con que tropiezan los autores sobre el final del trabajo.

Me limitaré a comentar, a modo de ejemplo, una de estas afirmaciones: “generalmente son personas que durante su infancia sufren más separaciones familiares, lo que los lleva a desarrollar un modelo de continua separación y regreso a su familia”.

Proponer tal inferencia resulta incompatible con otras afirmaciones contenidas en el mismo trabajo ya que, por ejemplo “la muerte de los padres durante la niñez puede resultar finalmente en una genialidad si dicho duelo es sobrellevado en forma creativa”. No parece que sea en los acontecimientos donde encontremos las determinaciones sino en su significación. En otros términos, “es más significativo el contexto en el cual ocurre la crisis que el hecho traumático en sí”. O, aun, de otra manera: “El hombre vive en un ambiente tanto físico como simbólico y puede ser estimulado a actuar por símbolos... la respuesta de un hombre a un símbolo se realiza en términos de su significado y valor antes que en términos de la estimulación física que el mismo produce en sus órganos sensoriales” (Rose, 1962).

De todas maneras no se me ocurre el modo en que ese salto entre el conjunto de experiencias y la producción de significación pueda ser investigado. Tal vez desarrollos más recientes en el terreno

de la lingüística hayan acortado esa brecha, cosa que ignoro.

Una posibilidad, quizá, podría encontrarse en el uso de configuraciones interrelacionadas al modo de las cajas negras, propuesto por Sluzki y Verón (1970). Ello colocaría, de paso, en el terreno de pregunta no pertinente al dilema final que se les plantea a los investigadores, dado que se apoya en un modelo de causalidad no lineal.

Otra afirmación que ha merecido ya abundantes reflexiones es la que incluye el concepto de homeostasis. El modelo víctima-victimario que soporta tales afirmaciones no parece compatibilizarse con los lineamientos epistemológicos que guiaron esta investigación.

Tal vez el concepto de “coherencia” propuesto por Dell (1983), ofreciera una perspectiva teórica más consistente con esos fundamentos.

Por último, una reflexión acerca de un dilema que, creo, surge de los resultados de esta investigación. La comparación entre las variables discrimina a los adictos de los normales y de los pacientes psiquiátricos, del mismo modo que lo hace con los padres de los miembros de esos grupos, diferenciando a los padres de los adictos de los otros padres; puede así sostenerse la existencia de un modelo particular de vida. De ese modo, los valores obtenidos por los adictos, al ser evaluados en función de los mismos factores, resultan semejantes a los de sus padres.

Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia —ya que los padres no son adictos—, entre un sujeto adicto y otro que no lo sea? Pareciera que se pierde el poder de discriminación.

¿A qué categoría pertenecen los padres? Si no pertenecen al grupo de los adictos, ¿cómo es que los valores resultan significativamente equivalentes? Y si no pertenecen al grupo de los normales ni al de los pacientes psiquiátricos (ya que por transitividad de aquella equivalencia quedan excluidos), tal vez queden incluidos en el grupo intermedio de “tensionados”. Pero entonces, ¿qué diferencia existe entre un adicto y un miembro de este grupo?

Si bien la presente investigación apoya la idea de una estructura particular para la adicción, la experiencia clínica parece más bien inclinarse a definirla como un síntoma que puede ponerse de manifiesto en cualquier estructura psicopatológica.

¿No sería más consistente con un enfoque familiar sistémico descentrarse del síntoma individual para poder sostener —como a mi entender hacen los autores—, una diferencia a nivel de los modelos? Ellos contendrían las condiciones esenciales para la producción de un síntoma de adicción o de otros que, desde un punto de vista teórico, resulten equivalentes.

El título del trabajo, “Ciclo de vida y abandono”, parece apuntar justamente hacia la elucidación de esos modelos.

BIBLIOGRAFIA

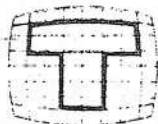
- BATESON, G.: *Pasos hacia una ecología de la mente*, Lohlé, 1976.
- DELL, P.F.: “Más allá de la homeostasis”, *Terapia Familiar*, Año VI, No 11, 1983.
- NOCETTI, J.C.: *Psicoanálisis de las relaciones familiares*, Torres Agüero, Bs. As., 1983.
- “Las relaciones familiares se estructuran como un relato”, *Revista Argentina de Psicología*, Año XIV, No 34, 1983.

ROSE, A.M.: *Human Behaviour and Social Processes, an international approach*, Routledge y Kegan, Londres, 1962.

VERON, E.: "Perspectivas futuras de la investigación básica sociocultural en salud men-

tal", *Acta Psiqu. y Psicol. Amer. Lat.*, Vol. XV, N° 3, 1968.

VERON, E. y SLUZKI, C.E.: *Comunicación y neurosis*, Editorial del Instituto, Bs. As. 1970.



**ELECTRONICA
TECHISERV SRL**

**SERVICIOS DE VIDEO
GRABACIONES Y PROYECCIONES DE VIDEOS
ALQUILER DE PROYECTORES DE PANTALLA
AMPLIADA DE VIDEO, MONITORES
Y VIDEO-CASSETERAS**

Alquiler de Equipos para Congresos, Seminarios, etc.
Proyectores de Pantalla Ampliada, Monitores, VCR
Sistemas de Sonido con y sin Operador, Micrófonos,
Traducción Simultánea
Grabación y Descodificación de Material de Video
Servicio Técnico de Equipos Electrónicos
e Instalación y Asesoramiento de Cámaras Gessel

Av. CRAMER 2475 1428 CAPITAL FEDERAL
Tel.: 544-0440

Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux

Directeur des cahiers
Mony Elkaim

Responsables de la coordination
Edith Goldbeter & Eric Trappeniers

Pourquoi ces cahiers?

Etait-il nécessaire d'ajouter aux multiples revues
de thérapie familiale une nouvelle mouture française?



Nous souhaitons répondre à 3 types de préoccupations:

- Ouvrir un débat théorico-technique sur nos pratiques en thérapie familiale
- Elargir ce débat à tous ceux qui, de différentes manières, remettent en question les institutions et les pratiques actuelles dans le champ de la santé mentale
- Mettre à disposition du public francophone des documents internationaux concernant ce domaine.

Ces cahiers sont réalisés en collaboration avec les revues "Family Process" (New York) & "Terapia Familiare" (Rome) et paraissent deux fois l'an.

Pour toute demande d'abonnement, écrire à:
Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux
Editions Privat

14, rue des Arts / 31068 Toulouse Cedex / France

Prix de l'abonnement pour deux numéros:
190 FF (France) ou 240 FF (Etranger)

Somme à envoyer au CCP Toulouse 1172-40B avec la mention:
"Abonnement aux cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques
de réseaux".

terapia familiare

rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale

The Journal is published quarterly (March, July, November) by the Rome Family Therapy Institute.

Editor in Chief: M. Andolfi.

Editorial board: P. Menghi, A. Nicolò, C. Saccu

Its aim is to promote research and present studies in the following areas:

- ☐ Theory and practice of family therapy
- ☐ Training in family and marriage therapy
- ☐ The individual, the family, social systems and their correlates (schools, neighborhoods, social and health services, etc.) from a systems point of view.



The journal is published in conjunction with: *Family Process, Journal of Marital and Family Therapy, The American Journal of Family Therapy.*

The journal, established in 1977, has been the only Italian publication in the field of family psychotherapy. It has always been active in the cultural and scientific debate in this field both in Europe and in America.

It includes contributions by:

H. Aponte, L. Boscolo, D. Bloch, I. Boszormenyi-Nagy, M. Bowen, P. Caillé, G. Cecchin, M. Elkaim, J. Framo, J. Haley, K. La Perrière, S. Minuchin, P. Papp, G. Prata, M. Selvini Palazzoli, H. Stierlin, C. Sluzki, P. Watzlawick, C. Whitaker, I. Zwerling.

One year subscription

Europe: u.s. \$ 25
Extra-European countries: u.s. \$ 30

Checks payable to:

I.T.F., s.r.l. - Via Reno, 30 - 00198 Roma

Respetar la creatividad del Terapeuta. Análisis de una Supervisión centrada sobre el Sistema Terapéutico.

DR. L. CANCRINI

Profesor de Psiquiatría y de Psicología de la Universidad de Roma.
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. 2, via Falopio
I-00161 Roma, Italia.

Artículo traducido de: *Thérapie Familiale*.
Genève, 1987, Vol. 8, N° 1, pp. 45-58.

Traducción: Lic. Inés Dates

EL CASO DE ANDREA

Andrea, de 26 años, es el segundo de tres hermanos. La hermana mayor, Cinzia, y Marco, el hermano menor, están casados y ya no viven en la casa. Desde el segundo de esos matrimonios, hace dos años, Andrea dejó de trabajar, empezó a drogarse y volvió a vivir con sus padres; esto, luego de haber vivido en otra ciudad por largo tiempo. La familia, muy unida, descubre enseguida la toxicomanía. Hay numerosos intentos de terapia. Andrea se inyecta regularmente, pero sin incidentes. Trabaja desde hace un tiempo en el negocio de su padre.

Al comienzo, la terapia familiar da rápidamente brillantes resultados. Andrea no se droga más, se hace claramente más autónomo en relación a su familia. Durante la segunda fase de la terapia, el trabajo centrado en la pareja parental parecía desarrollarse bien. Durante diez sesiones repartidas en casi cuatro meses, la familia mostró dócilmente en sesión el comportamiento ideal de la familia que viene a terapia "para curarse enseguida".

De repente, durante las vacaciones de verano, ocurre el accidente. Andrea intenta suicidarse, sin que la familia pueda entender por qué. Su estado es grave durante dos días, luego mejora y puede salir del hospital. Después de un momento de pánico, la familia recompone su unión, más sólidamente que antes. Su comportamiento es tan desenvuelto que los terapeutas se encuentran muy inquietos.

LA PRESENTACION DEL CASO

Cuando los terapeutas presentan el caso de Andrea y de su familia, parecen próximos a rendirse. Hablan sin interrupción durante cerca de una hora. En su exposición, hacen a veces alusión al hecho de que algún otro podría tomar a su cargo a la familia, pero su informe es confuso y los pedidos de aclaración no obtienen respuestas apropiadas: el grupo y el supervisor se encuentran frente a una ensalada de razonamientos y de hipótesis que los ponen incómodos hasta darles la impresión "delirante" de que los terapeutas están engañándolos. Se hace más y más claro en esta situación que es imposible utilizar la comunicación verbal de los terapeutas.

El conocer a los dos terapeutas hace que sea particularmente difícil comprender lo que pasa. El supervisor sintió con una ansiedad cercana al pánico la dificultad que había para comprender algo de la familia, lo que enseguida le hace pensar que algo parecido pudiera haber pasado recientemente entre la familia y los terapeutas. Entonces es posible que los terapeutas intenten voluntariamente hacer caer al grupo en la misma trampa a que los arrastró la familia, es decir en un juego de espejos enfrentados, sostenido por el mecanismo que Jackson llamaba "inducción".¹

Partiendo de esta hipótesis, el supervisor consagra los últimos minutos de la hora de trabajo a hacer lo que le parece más razonable.

La primera intervención de supervisión: reconstruir un contexto terapéutico

En adelante reproducimos casi literalmente lo que dijo el supervisor en esa ocasión. Habló afectuosamente y con vacilación. Ha intercalado explicaciones bajo forma

1. Jackson y Weakland distinguen la "inducción" (mecanismo por el cual el sistema tiende a someter a sus reglas el comportamiento del terapeuta o de una persona externa) de la "contratransferencia" descrita por el psicoanálisis. Lo que ocurre en terapia familiar es, según ellos, más bien una distorsión paratáctica (de parte del paciente y del terapeuta: "una mezcla de ignorancia y de desinformación sobre lo que se puede esperar legítimamente") en el sentido propuesto por H.S. Sullivan. (Jackson y Weakland, "Conjoint Family Therapy: Some Considerations on Theory, Technique and Results", *Psychiatry*, Vol. 24, supl. 2, 30-45, 1961.

de comentarios que muestran la complejidad de la intervención, así como extractos del diario escrito por los terapeutas. Sin embargo, el supervisor no tenía presentes, en el momento de su intervención, la inmensa mayoría de los razonamientos y de las implicancias que aparecen en este artículo. Todo esto se ordenaba naturalmente, como cuando diferentes elementos del habla se conjugan al comunicarnos con alguien sobre temas complejos en la vida cotidiana o en el trabajo.²

Supervisor: Me parece que esta familia, desde el comienzo, hace como si fuera un ilusionista . . . como un ilusionista que saca todo tipo de cosas de su sombrero, en el momento en que ustedes menos se lo esperan . . . pero cuidado: esto podría ser su estilo, su forma de comunicar, y no una respuesta a los movimientos de los terapeutas . . . Debemos enfrentar el grave problema de un estilo de comunicación que consiste en decir con las palabras que

2. En el estadio, un padre se enoja contra su hijo de 10 años, le da una bofetada, lo regaña. Hay una clara desproporción entre la acción del niño y la reacción del padre. Varias personas querían intervenir pero no lo hacen y el padre se detiene. Ahora está en dificultades y no sabe cómo salir de la situación desagradable que él mismo ha contribuido a crear. Mientras que todos los otros están turbados, avergonzados y se callan, lo que aumenta el malestar del padre, un amigo comienza un discurso diferente acercándosele y poniendo dos veces la mano sobre su hombro. La tensión se deshace rápidamente y el padre se acerca a su hijo que lo acepta. Pregunta: ¿cuántas páginas se podrían escribir para describir las implicancias complejas de esta intervención terapéutica "natural" (o, desde otro punto de vista, de esta supervisión)?

todo va bien y con los actos que hay problemas. Esta familia emplea las palabras como si fuera un intercambio de mercaderías, no como medio de información.

Comentario: El supervisor se refiere a la tentativa de suicidio pero también a otros episodios no mencionados aquí y los utiliza en una definición global de la situación. Saltando limpiamente por sobre los contenidos, muestra un tipo recurrente de interacciones entre la familia y los terapeutas. La imagen de los ilusionistas sirve para acentuar las dificultades de la terapia, de las que nos damos cuenta, más que por el informe, por el miedo vivido por el supervisor mientras los terapeutas hablaban. Al atribuir a la familia y a su estilo el origen del impasse que hay que vencer, el supervisor: a) ayuda a los terapeutas a recuperar una situación exterior a la familia (hipótesis confirmada por las vivencias de los terapeutas), b) neutraliza su tendencia a culpabilizarse y la otra tendencia que está ligada a ésta, la de desafiar al supervisor y al grupo. "La verdadera razón de la dificultad de trabajar en base a un simple informe es el estilo de comunicación de esta familia". Se pone provisoriamente a la familia en el lugar del enemigo exterior frente al que los terapeutas y el grupo pueden unirse.³

3. Este paso es necesario por el estado de confusión en el que se encuentran los terapeutas. Vehiculiza un mensaje de afecto y de profunda solidaridad que "toca" con la misma simplicidad ilógica que aparece en la nota 2. Por una especie de pudor que merecería ser mejor analizado, hasta el momento se ha reflexionado poco sobre los pasos "ilógicos" en la terapia de supervisión.

Supervisor: Quizás se debería empezar una nueva fase de terapia. Sí, exactamente eso, una nueva fase de terapia porque ya se hizo un buen trabajo y porque la familia nos enfrenta, ahora, con un problema que todavía no ha sido abordado. Para poder hacerlo, les propongo hacer una sesión con nosotros, para crear una ruptura con el pasado, para liberarlos de la trampa en la que están metidos.

Comentario: De todas formas, que esté claro que la terapia es de ustedes y que nadie tiene la intención de a) aceptar delegaciones, b) intervenir su lugar. Los supervisores tranquilizan a los terapeutas: su territorio no será invadido. El único problema consiste en pasar a la fase siguiente, sin renegar de nada de lo que ha ocurrido sino usándolo todo para una nueva fase terapéutica.

("Al definirnlos como terminando una fase, escribieron los terapeutas, el supervisor había "interpretado" nuestro deseo de liberarnos de esta familia transformándolo en una actitud terapéutica").

COMENTARIO

Técnicamente, el interés de esta intervención parece ligado a: a) el uso de elementos ligados a las redundancias del sistema terapéutico (más que de la familia), b) a la tentativa de recrear una frontera entre el supervisor, terapeutas y entre el sub-sistema de los terapeutas y el de la familia, c) a la complejidad del mensaje contenido en la propuesta de pasar a una segunda fase de la *terapia ya en curso*: al redefinir positivamente el trabajo ya hecho, uno se muestra respetuoso de los terapeutas mientras que por el mismo movimiento se per-

mite que un trabajo "completamente nuevo" pueda desarrollarse.

A continuación veremos cómo el punto a) será útil para preparar una intervención terapéutica que el supervisor y los terapeutas consideran crucial mientras que b) y c) indican el camino por el que nos dirigiremos a partir de la próxima sesión para hacer posible esta intervención.

Teóricamente, el interés de esta supervisión reside en la decisión de no sólo utilizar el material presentado por los terapeutas, sino también las emociones suscitadas en el supervisor por su informe.

A este respecto Searles escribe: "Durante la relación con el terapeuta, el supervisor experimenta una gama de fenómenos afectivos tan vasta como la del terapeuta o aún la del paciente, aunque en realidad las emociones del supervisor son menos intensas que las del terapeuta y generalmente muchos menos intensas que las del paciente. Además, el supervisor descubre frecuentemente que estas emociones que surgen en él no son cuerpos extraños, fenómenos clásicos de contra-transferencia, sino que son *reflejos, bastante útiles desde el punto de vista del conocimiento, de la relación que existe entre el paciente y terapeuta*. A este fenómeno lo llamaría proceso de reflexión. Utilizaría este término sobre todo por amor a la concisión y además porque quería poner de relieve el particular origen de las emociones que quiero examinar".

Y más adelante: "Cuando el supervisor descubre que experimenta emociones durante la sesión de supervisión, hay que prestar atención no sólo a la posibilidad de que la fuente de esas emociones esté sobre todo enterrada en su pasado, reactualizada en el momento, en cuyo caso

vive una reacción contratransferencial clásica con respecto al terapeuta; también deberá estar atento a la posibilidad de que el origen de esas emociones esté situado específicamente en la relación paciente-terapeuta, y fundamentalmente, sobre todo en el paciente mismo. Si se trata de esta última posibilidad, podemos decir que la emoción del terapeuta es el reflejo de algo que ocurrió en la relación terapeuta-paciente y, en el último análisis, en el paciente mismo.

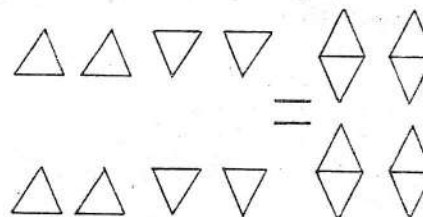
No hay que creer que este proceso de reflexión esté siempre en primer plano de la situación de supervisión. En la práctica, probablemente no comprende más que una pequeña parte de lo que ocurre en una sesión de supervisión. Sin embargo, tiene un papel esencial, puesto que *puede ofrecer indicios que iluminen las dificultades oscuras que existen en la relación paciente-terapeuta*".⁴

4. Searles, H.F.: "The Informational Value of the Supervisor's Emotional Experiences", en *Collected Papers on Schizophrenia and Related Subjects*, Hogard Press, London, 1965; P. 157-176. El artículo que contiene numerosos ejemplos clínicos, comprende una revisión de la literatura sobre la utilización, en la cura, de las emociones suscitadas en el terapeuta por el paciente. Siguiendo a Searles, el término contratransferencia no se aplica a todos estos fenómenos con todo rigor. Sólo concierne a la evocación en el terapeuta, de emociones que provienen de su infancia y que pueden ser vividas "como si fueran una reacción en la realidad a la relación con el terapeuta, lo que en realidad no son". Esta distinción, que me parece difícil sostener en el plano teórico y que el texto del libro no toma en cuenta, es útil en la práctica para recordarse que todas las emociones del supervisor (o terapeuta) no son inmediatamente utilizables en la supervisión (o la cura). Ver

Es interesante ver cómo fue utilizado ese "reflejo" del supervisor. Sobre este tema, podemos adelantar la idea que los terapeutas proveyeron información de tres tipos a propósito de su trabajo: a) informaciones (nuevas) que sirvieron para definir la historia y la organización de esta familia, b) informaciones sobre el contexto de la terapia, informaciones sobre su implicación, por ejemplo sobre las formas y la evolución de su relación con la familia, c) informaciones indirectas, *evocadas o suscitadas en la persona del supervisor* a través de la manifestación en el aquí y ahora de las formas que tomó su dificultad.

Al intentar ver de qué manera estos tres órdenes de información se ligan entre ellos para tomar un sentido, podemos decir que el supervisor sólo utiliza las informaciones una vez que han tomado una forma significativa, lo que sólo ocurre cuando las informaciones de que se trata en b) dan un sentido al (o toman su sentido del) reflejo del que se trata en la letra a). (Fig. 1).

Informaciones sobre la familia +
Informaciones sobre la terapia.



también los ejemplos clínicos enfocados en el artículo "The Schizophrenic Vulnerability to the Therapist Unconscious Processes", *ibidem*, p. 192-215.

y la significación transmitida (letra c) del texto) se indica por la forma:



FIGURA 1

Pensemos, para comprender mejor esta transición, en otra observación hecha en un marco de tipo psicoanalítico, y sobre la comunicación de *orientaciones de significados* que permiten dar sentido a un grupo de comunicaciones sin lazo aparente entre ellas, por medio de las emociones suscitadas en el terapeuta o del supervisor.

"Creo, escribe Bion, que ya les ha ocurrido en sesión algo que me ocurre a menudo. Me ocurre que busco mentalmente analogías con ciertas escenas, como la preparación del bebé para el baño o la mamada, o el cambio de pañales, o una seducción sexual. Muy a menudo, se tiene la impresión de asistir a algo que es una mezcla de partes de estas escenas; esto me ha conducido a pensar que en estos casos, lo que tengo en la cabeza es una actividad ideomotriz, es decir una manera de expresar una idea que no tiene definición verbal".⁵

Terminaría este punto volviendo a proponer una exigencia crucial en el debate moderno sobre la psicoterapia. Si es cierto que fenómenos descritos en contextos tan diferentes como el psicoanálisis y la

5. Bion, R.W., *Analisi degli schizofrenici e metodo psicanalitico*, Armando, Roma, 1970.

terapia familiar presentan analogías formales de tal amplitud, ¿no sería útil e interesante para todo el mundo abandonar los nidos abrigados donde una estrecha visión de escuela encierra tantos discursos y prácticas terapéuticas?

La segunda intervención de supervisión

Cuando la familia viene a la siguiente cita, ya había sido avisada por los terapeutas de la presencia del supervisor. El lugar de la cita, diferente del habitual, la hora diferente, el espejo sin azogue, señalan el significado de acontecimiento "excepcional" que los terapeutas dan al encuentro. El hecho de que los terapeutas hayan propuesto estas modificaciones con el objetivo de mejorar el trabajo terapéutico y que la familia las haya aceptado, ya contribuyó a redefinir la existencia de una frontera entre familia y terapeutas. Pero ahora hay que evitar que la conversación vuelva a desarrollarse como otras veces, lo que anularía el efecto de esas novedades. El supervisor teme sobre todo que la sesión gire en torno de un informe más o menos detallado de los acontecimientos de la semana transcurrida. Este tipo de informe puede ser muy útil en terapia familiar, por ejemplo al comienzo de la terapia, cuando se quiere circunscribir temporalmente un problema para identificarlo mejor o cuando queremos estudiar las retroacciones de la familia a una acción de los terapeutas. Pero cuando los terapeutas, como ahora, están en dificultades, nos arriesgamos a perdernos en una multitud de comunicaciones insignificantes y contradictorias. Si ocurriera esto, aún hoy, la vuelta a la situación precedente sería inevitable.⁶

6. Desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, el sistema terapéutico anularía (concepto de homeostasis) la novedad propuesta por el trabajo de supervisión. El supervisor debe saberlo: desde el comienzo de una terapia, trabaja con un sistema del que forman parte los terapeutas...

Para evitar esta dificultad, damos un consejo a los terapeutas. Después de los saludos habituales (la "fase social" de la terapia, en el sentido propuesto por Haley), deberán pedir a cada miembro de la familia que "haga un ejercicio de fantasía, diciéndonos cómo cada uno imagina a su familia dentro de dos años". Más allá de los contenidos, lo esencial es que los terapeutas tengan claro que quieren que se produzca un discurso nuevo en la sesión, y un punto desde el cual hacerlo comenzar.⁷ Así se los empuja a evitar una vuelta a situaciones precedentes. Por otro lado, también se empuja a los terapeutas a reafirmar, tanto para sí mismos como para la familia, que a) ellos son responsables de la terapia y la dirigen; b) que la terapia se destina a la familia y no a ellos.

Como lo habíamos previsto, la familia comienza por un informe contradictorio (en lo que concierne a los hechos) y concordante (en el no tomar nota de las contradicciones). Pero la situación no se degrada, porque los terapeutas no se dejan implicar en el juego. Los terapeutas anotarán en su diario que la "utilidad de la

6. Desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, el sistema terapéutico anularía (concepto de homeostasis) la novedad propuesta por el trabajo de supervisión. El supervisor debe saberlo: desde el comienzo de una terapia, trabaja con un sistema del que forman parte los terapeutas...

7. Este consejo es sacado del que yo escribí de Sal Minuchin hace muchos años; me dijo: "Si te sientes en dificultades durante una terapia familiar, siempre puedes pedirles a los miembros de una familia que imaginen su porvenir, qué tipo de abuelos van a ser sus padres, etc... Eso te va a dar información útil y va a volver a cada uno a su lugar".

supervisión precedente consiste en el hecho de que ahora podemos sobrevolar las comunicaciones contradictorias de la familia. La idea de algo definido para hacer (la pregunta sobre el futuro) nos permitió darnos cuenta de la manera como la familia *encubría sus conflictos...*

Al pensar en una consigna rígida sobre "la imaginación", los terapeutas alcanzan a evitar el juego habitual de la familia *porque lo advierten*: la presentación y la ocultación del conflicto.⁸

La sesión continúa así, sin problemas especiales, durante cerca de una hora. En el plano de los contenidos, los padres tienen tendencia a centrar sus fantasías sobre Andrea que acepta fácilmente esa tendencia y la refuerza. En el plano de las transacciones, se confirma la tendencia a la ocultación inmediata de los conflictos, así como el papel crucial de Andrea en este proceso. Por ejemplo, cuando los terapeutas muestran las divergencias entre las hipótesis sobre el futuro del padre y de la madre, Andrea interviene enseguida intentando minimizarlas ("no es más que imaginación"). Más adelante, cuando los terapeutas insistan para saber qué será de los padres, Andrea explica que todo depende de él. "Ellos viven juntos serenamente: si yo ando bien, ellos andan bien. Me dejan en casa y van a cenar afuera". Cuando él dice esto, el ambiente se hace todavía más distendido, si ello fuera posible: los padres hablan de su amor y de su

felicidad. Los terapeutas escriben: "El mensaje de la familia es compacto: en casa reina la felicidad. El juego que discutimos al comienzo de la sesión es redundante. Jugándolo, los miembros de la familia impiden las tentativas de diferenciación; nos recuerdan a una piña de pino verde, totalmente cerrada".⁹

La retroacción de la familia impresiona positivamente al grupo y al supervisor. La familia aceptó sin problemas las novedades introducidas en el "setting", la actitud más desligada y profesional de los terapeutas. El juego es tan claro e ingenuo que ilumina con una luz nueva a la "curación" (o la "huída a la curación") de las primeras sesiones y el episodio "curioso" que puso en dificultades a los terapeutas. La desaparición inmediata de las tensiones luego del comienzo de la terapia y de la tentativa de suicidio de Andrea no son una manera de ocultar el problema de la familia, sino que es la expresión directa e inmediata de su problema más grave: la incapacidad de mantener abiertos (y por ende enfrentar) durante un lapso de tiempo razonable los conflictos que se manifiestan en la pareja parental.¹⁰

9. Cosentini, *ibidem*, p. 50.

10. Una dificultad tan importante y constante para enfrentar los conflictos no es frecuente en familias con un paciente designado toxicómano. Se la encuentra sobre todo en las familias en transacción psicótica pero en éstas los niveles de fragmentación de la comunicación verbal están más marcados que en una familia como ésta. Para hacer un paralelo con un diagnóstico individual, el problema de esta familia podría ser de tipo clínico. Sobre este asunto, ver Cancrini L. Una tipología de la toxicomanía. *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, 1982, Nro. 6.

8. María Antonietta Cosentini: Contributo per un metodo di analisi e di intervento delle tossicodipendenze: alcune idee sulla formazione permanente degli operatori; tesi di diploma in psichiatria, Roma 1983, p. 43.

Ya es tiempo de una intervención más incisiva. Los terapeutas, después de haber consultado con su supervisor, se despiden de la familia por media hora.

Una previsión paradójica construida durante la supervisión

Esta prescripción, basada sobre la tentativa de aceptar y alentar el movimiento natural de la familia, es elaborada cuidadosamente durante la interrupción. Esto es lo que se transmitió a la familia.

Terapeuta: Hay algo muy hermoso en su familia, el que no haya nunca disensiones, especialmente entre ustedes (se dirige al padre y a la madre), nunca nadie se la toma con otro, nunca nadie va contra otro. Es muy hermoso. Este aspecto de las cosas nos ha dejado estupefactos, no tanto a nosotros, que los conocíamos, sino sobre todo a nuestro consultor.

También pensamos en uno de nuestros errores en esta terapia: durante largo tiempo, hemos intentado que ustedes se peleen, hacer que surjan los enojos, los desentendimientos entre ustedes y, quien sabe (y acá el terapeuta cambia de tono, se pone azorado y preocupado) si no es esto lo que condujo a Andrea a hacer ese acto que nos asustó a todos... a la idea de morir. No lo sabemos... Lo que es seguro es que ahora sentimos la cosa de manera diferente. Querríamos ayudarles a seguir por ese camino, el camino donde no hay peleas ni acusaciones. Es muy interesante porque los miembros de las familias donde hay un hijo que se droga, se acechan entre sí, se acusan recíprocamente de ser responsables de los problemas. Pensamos que este aspecto los diferencia de los otros, que es muy bueno y que debe ser respetado, pero pensamos que es

muy difícil poder mantener esa posición sin desfallecer nunca. Pensamos que debe ser extremadamente difícil y pesado para ustedes y quizás hay algunos chirridos... Después de todo, creemos que quizás esa sea la razón por la que todavía nos vemos y pensamos que debemos ayudarlos a mantener esa armonía a la que todos tienen.

Por eso querríamos que durante esta semana, cada uno de ustedes trate de escuchar su voz interior en los momentos de dificultad. Y esto para mantener su armonía, evitando la tentación de quebrarla. Y si fuera posible, hagan esto sin comunicárselo a los otros. Quizás esta semana esto ocurra mucho menos a menudo, pero si ocurre, deberéis prestarle mucha atención: cuando nos veamos la semana que viene, trataremos de ayudar a cada uno de ustedes a que la situación chirrre un poco menos.

Madre: Muy bien.

Padre: Estoy de acuerdo.

Padre: (levantándose) Es verdad, somos realmente así.

Terapeuta: (en la puerta) Estos rechimientos podrían ser un dolor de cabeza para mamá, una inyección de Andrea, la irritación de papá con el abuelo...

La prescripción

Podemos estudiar esta prescripción a varios niveles. Refiero a los *terapeutas* a los textos clásicos sobre contraparádoja y para los *formadores* destaco:

a) Que connotamos positivamente una regla familiar extendida al conjunto del sistema terapéutico, es decir que la prescripción se dirige al sistema terapéutico en su conjunto, al sistema te-

rapéutico más que a la familia en sí. En esto, se diferencia de las prescripciones que se dirigen más específicamente a la familia y que contienen alusiones más pertinentes a la historia y al mito que la gobierna.¹¹

b) que los comportamientos sintomáticos son connotados de manera aparentemente contradictoria: la tentativa de suicidio, hecho nuevo e inaceptable para la familia, es presentado como una consecuencia del error de los terapeutas que habían intentado cambiar a la familia mientras que se consideran simples "rechimientos" ligados a la dificultad de mantener el equilibrio, que ha sido connotado positivamente, a las cefaleas de la madre (frecuentes durante la terapia), los toxicomanías de Andrea y la irritación anunciada y negada del padre hacia su suegro;

c) que se preparó con cuidado la división en dos partes del discurso de los terapeutas: la alusión al síntoma hecha como por casualidad en la puerta al despedirse, es un momento clave de la intervención. Estas alusiones hubieran quizás suscitado vivas resistencias si hubieran tenido lugar en otro momento.¹² Es importante programar también

los puntos muertos de la escena terapéutica (aquí el momento de los saludos) durante los cuales los terapeutas jóvenes o demasiado implicados son susceptibles de "bajar la guardia" y de permitir a la familia descalificar o anular la prescripción.¹³

Pero lo que más me interesa es el sentido que toma la prescripción en el contexto de supervisión que le dio nacimiento. Notemos el significativo lazo entre los contenidos de la prescripción y la primera sesión de supervisión. Los terapeutas hablan muchas veces de una nueva fase de la terapia. Muchas veces la relacionan con un elemento que les permite ver los mismos problemas desde un punto de vista diferente.

En la intervención actual, los terapeutas no niegan la fase anterior del trabajo,

refuerzo de sus "resistencias". La intervención hecha en la puerta se parece a las instrucciones transmitidas durante el trance. En términos de comunicación, se connotan comportamientos que la familia vive como espontáneos e incontrolables atribuyéndoles un sentido inesperado para los miembros de la familia. El objetivo del terapeuta es el siguiente: cuando estos comportamientos se repitan, la familia los percibirá de un modo diferente y entonces deberá buscar:

a) nuevas formas de conceptualización de la experiencia recíproca;
b) respuestas apropiadas. Cancrini L, *Guía alla psicoterapia*. Editori Riuniti. Roma, 1982, Cap. VII.

13. Selvini y colaboradores proponen técnicas específicas para prevenir este obstáculo: el terapeuta "lee" de pie su prescripción y considera que todo lo que ocurre en los instantes que siguen es de una importancia extraordinaria para su trabajo. La continuación del trabajo mostró que la preocupación era necesaria en este caso. (Cosentini, op. cit.).

11. Lo que, de hecho, quiere decir que la prescripción tiende a encaminar los procesos propios del sistema terapéutico más que a provocar un cambio en la familia; en la práctica, igual habrá un cambio, pero la distinción sigue siendo fundamental en el plano teórico.

12. Al discutir este problema a partir del punto de vista de Erikson y de Haley, podríamos decir que provocamos un "trance" hipnótico en la familia a través del largo discurso de

simplemente se le da el sentido de una prueba: sólo probando *antes* la reactividad de la familia ha sido posible comprender después sus particularidades, lo que la hace diferente de otras, y por ende accesible a la terapia. La actitud de los terapeutas ha cambiado, están de nuevo a una distancia correcta de la familia que se les abre. Todo ocurre como si la fuerza del punto de vista que emergió en la supervisión hubiera permitido un *cambio de comprensión*.

La supervisión permitió poner en práctica proyectos que ya estaban presentes en los terapeutas, pero cuya puesta en práctica estaba impedida por la inducción de la familia. La supervisión puede entonces ser descrita como un intento de liberar potencialidades a través del reaseguro (las justificaciones teóricas) y el ejemplo (el consejo directo). El terapeuta experimentado es el que ayuda a los otros a utilizar su "voz interior" cuando su equilibrio de base, su formación precedente y la construcción de un contexto apropiado para la terapia los ponen en buenas condiciones para oír esa voz.¹⁴

Comentario

El conjunto de estas observaciones permite hacer otra, más general. Me parece muy importante asir, en la simplicidad de estos momentos, en la facilidad con que personas diferentes los realizan utilizando las mismas vías, uno de los misterios más apa-

sionantes del trabajo psicoterapéutico: una simplicidad de lenguaje y una comprensión universal que permiten sentir por qué es posible trabajar "interpretando" con un niño de dos o tres años, con un psicótico en grave regresión, con hombres y mujeres de buen nivel cultural. ¿Acaso no es verdad que el elemento que caracteriza a los seres humanos y hace sus historias únicas no es una verdad que existe en ellos o en sus grupos sino sólo "una escritura posible en torno a esa verdad"?¹⁵ Si lo que ocurre en un individuo o una familia no es accesible directamente sino sólo a través de las situaciones creadas por el observador, lo que interesa al terapeuta es el prisma, y no la luz que refracta, la modalidad única de su composición y no la monotonía confusa y engeñecedora de su fuente.¹⁶

Todavía dos comentarios prácticos sobre los niveles de implicación del supervisor y sobre la forma elegida para la intervención.

Al aceptar el papel que se le impone, el supervisor participa en su propio nombre en la preparación y el desarrollo de la sesión. Si fallara la intervención que construyó y llevó a cabo con los terapeutas, po-

dría encontrarse implicado en el trabajo con esta familia durante mucho tiempo. Si la situación se desbloquea, como ocurrió en este caso, los terapeutas retoman la plena responsabilidad de la terapia.¹⁷

La forma elegida en esta intervención de supervisión se basa en la tentativa de crear condiciones útiles para el reconocimiento de un metatexto de los terapeutas, de su relatividad y de los límites que ello impone al desarrollo del trabajo terapéutico. No insistiré sobre este punto, que he discutido ampliamente en otro lugar¹⁸ y me limitaré a subrayar que alcanzamos este objetivo por medio del consejo sobre qué hacer. En mi experiencia, sólo se pueden utilizar este tipo de técnicas cuando un largo trabajo en común nos permite tener confianza en la relación establecida entre el supervisor y los terapeutas. Sólo se pueden aceptar consejos tan precisos si la relación complementaria y la posición baja de los terapeutas se limitan estrictamente al tema de que se trata. Si se percibe al supervisor como a alguien que tiene un punto de vista diferente del terapeuta, no es posible. En las situaciones intermedias, que son la mayoría, es

mejor que el supervisor no tome el riesgo.¹⁹

RESUMEN

El autor analiza la compleja intervención de un supervisor. Insiste en el respeto de la creatividad del terapeuta, derivado de las situaciones inspiradas por la situación terapéutica y de la experiencia emotiva del terapeuta. El análisis está centrado sobre todo en el papel que desempeñan los "reflejos" del supervisor y que forman parte de su implicación contra-transferencial. Finalmente, la construcción de una contraparoja frente al problema familiar es presentado como el resultado de una larga colaboración entre el supervisor y el terapeuta.

SUMMARY

The author reports the analysis of a complex supervisor's intervention. Respect for therapist's creativity is emphasized in the sense the supervisor should wait for solutions issued from the therapeutic si-

14. Desde este punto de vista podemos decir que el trabajo terapéutico se ejecuta casi simultáneamente contra (o a través) las resistencias de la familia (o del individuo), del terapeuta e, inevitablemente, del supervisor.

15. La expresión es de Giovanna Vennemann, en: Uno Stile (*Cosa freudiana*, 3 abril p. 1-6). Desde el punto de vista del inconsciente individual, la verdad inalcanzable a la que se refiere es el "Ello habla" de Jacques Lacan. A este respecto ver también Cancrini L., *Guida alla psicoterapia*, op. cit. Cap. X.

16. Matte Blanco J., *Unconscious as infinitely sets*, Duckworth, London. Expresa de una forma particularmente eficaz esta tesis de un gran interés desde un punto de vista rigurosamente psicoanalítico.

17. En lo que concierne a la continuación de esta terapia, Franco y Antonia vuelven a hablar de esta familia en supervisión dos semanas más tarde, sin pedir la presencia de la familia. En esta ocasión discutimos las reacciones de la familia a la prescripción y la sorpresa que, al comienzo, ella provocó en los terapeutas. Luego, el trabajo terapéutico continuó con buenos resultados, sin que los terapeutas recurrieran a la supervisión. Co-sentini A., op. cit.

18. Cancrini L., "Quattro prove per l'insegnamento della psicoterapia", *Nuova Italia Scientifica*, Roma, 1984.

19. En mi experiencia, la actitud de un didacta del Instituto de Psicoanálisis me hirió mucho y no me ayudó en mi crecimiento personal ni en la terapia de la que le hablaba. El tenía la certeza, que yo no compartía, que la supervisión era un lugar de enseñanza. Mi rebelión, que se expresaba en atrasos repetidos, estaba basada en realidad en la necesidad de medir y mediatizar el discurso del psicoanálisis con otros enfoques. Esta necesidad no fue nunca explicitada y mi supervisor no se dio cuenta de ella o estimó écon justicia? que no debía tenerla en cuenta.

tuation and the therapist's emotional experience. Analysis is particularly focused on the role paper played by supervisor's "reflex" as a part of a countertransferential involvement. Finally, the construction of counterparadox facing the family paradox is presented as the result of a long, collaborative work by the supervisor and the therapist.

Comentario al artículo:

RESPETAR LA CREATIVIDAD DEL TERAPEUTA. ANALISIS DE UNA SUPERVISION CENTRADA SOBRE EL SISTEMA TERAPEUTICO.

Del Dr. L. Cancrini

Dr. ADOLFO LOKETEK

Médico Psiquiatra. Director General del Centro de Familias y Parejas (CEFYP)

Creo con el Dr. Cancrini que el objetivo de toda Supervisión es intentar desbloquear al equipo terapéutico, que ha tomado conciencia de su entrappe.

El campo de la supervisión define un lugar central: la relación supervisor-supervisado y un contexto, el sistema terapéutico. El supervisor interviene directamente (prioritariamente) en la relación supervisor-supervisado, para que éste intervenga directamente en el sistema terapéutico.

Dado que el pedido de auxilio proviene del terapeuta habría que ayudarlo, inicialmente a recortar el problema; el modo

Palabras claves

Supervisión

Creatividad del terapeuta

Contra paradoja

Key-words

Supervision

Therapist's creativity

Counter-paradox

de hacer dicho recorte dependerá del esquema referencial del supervisor, pero tener claro cuáles es la situación impotenzante es fundamental. Por situación impotenzante entiendo aquel subsistema individual/diádico/triádico, etc. . . y/o aquel contenido ante el cual no se encuentra alternativa útil.

También dependerá del esquema referencial las unidades de análisis que utilice el supervisor y cómo las jerarquice en su evaluación. Creo que Cancrini enfatiza el problema de la familia, la relación terapeuta/familia, relatada por el terapeuta, sus propias emociones y fantasías y seguramente la observación de la entrevista en vivo. Teniendo claro estos campos el *proceso de reflexión* manifestado en varias de estas áreas validaría, por consenso, las hipótesis que utilizemos (yo utilizo además el campo histórico —la generación anterior).

En el caso de Andrea la ansiedad por no entender fue vivida en todos los subsistemas involucrados. La secuencia: 1) no entiendo - 2) ansiedad/paranoide - 3) derivación a otro terapeuta, es transformada a otra secuencia: 1) no entiendo - 2) ansiedad paranoide - 3) derivación al subsiste-

ma supervisión - 4) entiendo . . . que la incapacidad de mantener abiertos durante un tiempo razonable los conflictos que se manifiestan en la pareja parental son el problema más grave de la familia . . .

¿Qué ha pasado?

Se han incluido: 1) un nuevo elemento (el supervisor), 2) un nuevo contenido técnico: ejercicios de fantasías, que inevitablemente producirán una crisis con una redefinición relacional. Ya no es el impacto producido por la familia sino el contra-impacto manejado por el terapeuta. Pero, ¿es ese el objetivo del espacio de supervisión? Creo que no, creo que hasta allí se han conformado los ingredientes necesarios para un nuevo saber.

El problema ahora para el supervisor es cómo hacer para que ese nuevo saber tranquilizador que está en el orden de la nueva estructura armada —inclusión de la persona del supervisor— quede incorporado en el sistema terapéutico una vez que aquel se haya retirado. Me estoy refiriendo a la búsqueda de un saber que es de otro orden que el reaseguro bibliográfico o el ejemplo por experiencia, como dice Cancrini, y que está quizás en el prisma, según la metáfora utilizada en el trabajo.

Yo creo que la experiencia de supervisión debe ser isomórfica de la experiencia terapéutica, entiendo por esto que supervisor y supervisado deben compartir (o por lo menos tener claro sus discrepancias) la visión sobre el ser humano, las relaciones familiares, la disfunción y el cambio.

Me parece que Cancrini no diferencia suficientemente la supervisión de una Terapia Familiar de la de una Terapia Individual, por eso toma conceptos provenientes del psicoanálisis individual, los extrapola directamente y comete el error de

hablar de la familia como un todo, como si fuera una unidad indiferenciada con lo cual puede considerarla como un individuo. Creo que si el supervisor detecta la confusión, el pánico, el ocultamiento, el juego de ilusionistas debiera acompañar al supervisado a buscar en qué subsistemas, en qué mensajes se da ese fenómeno y luego en quién se podría apoyar dentro del sistema familiar para buscar salidas. Esta manera de operar proviene de un pensar al individuo dentro de la familia, un pensar en el proceso de individuación, un pensar en límites intrafamiliares y no solamente en el límite terapeutas-familia. Comparto la inquietud de integrar los aportes de todas las escuelas, pero una cosa quiere decir integrar y otra mezclar/confundir.

Para integrar debemos diferenciar por lo menos las unidades de observación; un individuo no es un conjunto de individuos, un conjunto de individuos no es una familia.

Un último comentario sobre la creatividad, sobre ese proceso liberador que permitirá la emergencia de lo "nuevo" o lo bloqueado en el terapeuta, objetivo central de la experiencia de supervisión. No estoy de acuerdo con que la familia induzca en un terapeuta pasivo, creo que algunos miembros familiares "gatillan" algo que está en el terapeuta y que esto que ha sido gatillado promueve a su vez algo en la familia y así sucesivamente, circuito que podría puntuarse también desde el terapeuta y que algunas veces se convierte en redundante. Lo importante es que esta redundancia impide lo nuevo y el objetivo es sacar al terapeuta de la repetición a la cual potencializa por su propia estructura.

El espacio terapéutico no es un lugar donde se transmite lo elaborado en el espacio de supervisión, como si aquel fuera un escenario donde se representan libretos escritos en otro lugar: el terapeuta es un actor-director que está escribiendo permanentemente la nueva historia con la familia, por lo tanto lo sugerido en el trabajo de supervisión debiera ser a lo sumo como los primeros párrafos de un nuevo acto no escrito todavía.

Ahora bien, ¿existen indicadores de que el terapeuta ha recuperado su autonomía? ¿Sus miradas, sus preguntas, su escucha, son distintas a las del comienzo de la experiencia? ¿Ha enriquecido y complejizado su saber sobre los inevitables momentos de no saber-pánico-derivación que vivirá en el futuro? ¿Ha repensado

sus mecanismos de salida, en una pequeña vuelta sobre su propia historia? (reconozco que estas preguntas provienen de mi esquema referencial).

Un director teatral¹ me comentaba que lo que trataba de conseguir de sus actores era: 1) que se conecten con el pensamiento y el discurso del personaje, 2) que se conecten con las fantasías y las palabras que se le aparecieran, 3) que se conecten con un tercer nivel difícil de definir pero de adentro - emocional - corporal - histórico (la voz interior quizás) y que de esta complejidad debería salir lo nuevo, lo creativo, necesario para desprenderse de la dependencia reaseguradora (individuo-familia / familia-terapeuta / terapeuta-supervisor) y entregarse a la apasionante incertidumbre de la autonomía.²

NOTAS

1. F. Caicedo. Comunicación Personal.
2. "Un actor no puede dejar de representarse a sí mismo toda la vida, pero tiene que hacerlo en diferentes combinaciones y permutas de problemas y circunstancias dadas, que él mismo concibe para su papel y derrite en el horno de sus propios recuerdos emocionales, que son los mejores materiales para su labor creativa interior. De ahí que el actor siempre deba hacer uso de ellos y no confiar en lo que puede obtener de los demás". K. Stanislavsky; *El arte escénico*, "Introducción", pág. 60, Siglo Veintiuno Editores, Sexta Edición, 1979.

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, Palo Alto, CA

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, CHRM., Rochester, N.Y., Edgar H. Auerswald, Maui, Hawaii, Michael Goldstein, Los Angeles, Calif., Reuben Hill, Minneapolis, Minn., Arthur G. Rosenthal, Cambridge, Mass., Robert Ryder, Storrs, CT, Margaret T. Singer, Berkeley, Calif., M. Duncan Stanton, Philadelphia, Pa., Carl Whitaker, Madison, Wis.

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton.

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

Gentlemen:

DATE _____

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

- ☐ \$24.00 per year United States
☐ \$27.00 per year Canada & Latin America
☐ \$30.00 per year All other countries

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

- ☐ \$35.00 U.S.
☐ \$38.00 Canada & Latin America
☐ \$42.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____

STATE/COUNTRY _____

ZIP _____

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

Entrevista realizada a Luigi Cancrini en 1987

Por Lic. MARIA R. GLASSERMAN

Después de las presentaciones iniciales:

María Rosa Glasserman: —*¿Ud. está trabajando en drogadicción a nivel nacional o privado? Yo tengo entendido que Ud. trabajó en drogadicción a nivel nacional...*

Luigi Cancrini: —Yo tengo muchos años en el estudio de la familia y el drogadicto. Estoy realizando la 1ra. investigación en este tema desde el año 70. Soy considerado un experto en el tema, soy una persona que se escucha cuando se habla de esto. He trabajado por el partido comunista, en este tema.

He sido asesor de terapeutas familiares que trabajan con drogadicto, me interesé y soy curioso de toda forma de terapia de toxicómanos.

MRG: —*¿Conoce Ud. el proyecto Hombre de Roma? Yo le he visitado y me pareció interesante.*

LG: —Hay muchos intercambios que hemos hecho con este grupo.

MRG: —*En mi experiencia con drogadicto, uno no puede dejar de trabajar con la familia, por otra parte, pareciera, —es una visión mía— que el trabajo familiar solo a veces no alcanza, ¿Ud. qué piensa?*

LC: —La experiencia dice que en muchos casos sí es suficiente.

MRG: —*Tal vez tenga que ver con algún tipo de familia o con el modelo de abordaje.*

LC: —Bueno, tengo un grupo de terapeutas familiares que trabajan hace 7 años sólo con terapia familiar.

MRG: —*¿Con qué modelo?*

LC: —Nosotros distinguimos cuatro tipos de familia. Una tipología de toxicómanos, la B son toxicómanos neuróticos. En estos casos hay posibilidades de trabajo familiar de estilo estructural, con un trabajo sucesivo, que es un trabajo sobre la pareja de los padres, un trabajo en el tiempo, hay control del síntoma, el modelo de Jay Haley, es el modelo de Stanton y Todd.

Este tipo de terapia marcha con los toxicómanos de tipo neurótico. Hay otros tipos de toxicómanos que se tratan en familia que son de tipo transicional, por los cuales, la familia debe ser tratada de otra manera, con un estilo paradójico. Un tipo de trabajo no directo, no estructural. Son los de tipo C.

MRG: —*El A, ¿cuál es?*

LC: —El A es un tipo particular de toxicómanos en los cuales nosotros no involucramos familia, son jóvenes adultos en busca de organización personal en el sentido de Milton Erickson. Se encuentran con un duelo, con un trauma grave, y que encuentran una situación muy fuer-

te, una neurosis traumática en el sentido de Freud, toman droga y devienen toxicómanos. Para ellos, nosotros preferimos un tratamiento individual.

MRG: —¿No de comunidad?

LC: —No, sólo individual, de apoyo a ellos. La terapia de soporte, en el sentido de Bowlby.

MRG: —Este es el A, el B tratado estructuralmente, el C de tipo paradójal...

LC: —El C, psicótico, transicional, es parecido al tipo de familias que Mara Selvini Palazzoli describe en las anorexias.

Anorexias y toxicomanías. Las C son situaciones límites, tienen fases de comunicación congruente y fases de comunicación incongruente, tendencia victimal de las familias, tendencia a resolver las peleas presentándose como víctimas. Hay una involucración de ambos padres juntos. No hay un padre periférico ni una madre periférica. Hay una polarización de los hijos en el sentido de fracaso-éxito no de malo-bueno como en la familia del neurótico. Son diferencias clínicas interesantes. Hay particularmente una reacción de la familia a la propuesta de terapia que es muy contradictoria, con grandes movimientos de complicidad con la droga.

MRG: —¿Complicidad de los padres y/o de otros miembros de la familia?

LC: —De la familia, de cualquiera.

MRG: —¿Encubierta?

LC: —Sí, y de culpabilización, o de exceso de victimización, en el cual se dice que hay falta de esperanza.

En estos casos, la terapia, a la manera de Stanton y Todd, no marcha porque las tareas no serán cumplidas, etc. En esos casos nosotros trabajamos sobre el

síntoma mismo, y su significado. No centrar la terapia en una pelea contra... Es un punto de variación organizativa de la terapia muy importante.

Hay otro tipo de toxicómanos, sociopatas con los que no se puede trabajar con la familia porque hay una desorganización previa de la familia. Se utilizan conceptos sistémicos en una actividad, en el territorio, ¿no? No en el ambulatorio. En una casuística de B y C controlada después de 1 y 2 años después de la terapia, utilizando sólo la terapia familiar tenemos logrado éxitos en un 67% muy graves, muchos de ellos rechazados en las comunidades terapéuticas.

No fueron aceptados por ejemplo, por el proyecto Uomo que no toma pacientes donde hay evidencias que tengan trastornos psiquiátricos. Hay actualmente una organización convencional para la cual esta cooperativa recibe casos que no son aceptados por algunos de estos lugares. Es una ganancia el hecho de que no sean casos más fáciles.

MRG: —¿Seguro! Ahora, ¿dónde los atienden? ¿Pagan por esta atención?

LC: —No, no pagan por esta atención. Es un grupo que forma una cooperativa que está subvencionada por la región.

MRG: —¿Es algo oficial, reconocido...?

LC: —Sí.

MRG: —¿Cómo se llama?

LC: —¿La cooperativa? Albello, y hay otra cooperativa (con otro nombre) que está buscando hacer el mismo trabajo. Es muy popular, más pobre.

MRG: —¿Trabajaron con clase baja?

LC: —Con clase más baja, la otra es diferente, hay de todo.

MRG: —¿Es una muestra grande, pequeña? El universo... ¿cuantas familias?

LC: —Es una muestra de 104 familias con seguimiento de hasta 1 1/2 año después de finalizada la terapia.

MRG: —¿Cuál es el número de sesiones y el tiempo de estas terapias? La frecuencia entre sesiones.

LC: —Este es un grupo de psicólogos y psiquiatras entrenados como terapeutas familiares que recibieron además una supervisión semanal por 3 años.

En el caso de la terapia estructural se hace un trabajo de desintoxicación que es confiado a la familia en la casa. El terapeuta de Albello puede ser llamado y puede ir a la casa para ver cómo anda, pero el contrato es de 10 sesiones, en algunos casos se alarga. Se inicia semanal y luego se estira quincenal, mensual.

En el caso de la contraparádójica se inicia con sesiones de 15 días más regularmente y luego cada mes. Pero hay situaciones con las cuales con el tipo C se empieza de manera estructural y se convierte el trabajo. Cuando la familia fracasa en su tentativa de cambiar directamente.

Es la técnica de Philippe Caillé, movimiento antihomeostático. La duración es aproximadamente de un año. A veces un año y medio.

MRG: —Para Ud., particularmente, ¿tiene importancia el tema de la historia familiar en estos casos?

LC: —En estos casos sí, cuando se trabaja de manera paradójal; cuando uno trabaja de modo estructural, no.

MRG: —¿Quiere decir para los de tipo neuróticos no y los de tipo psicótico, sí?

LC: —Así es.

MRG: —Es una posición tomada pen-

sar que en algunos casos se puede trabajar con la historia y los otros no, ¿es verdad?

LC: —Es una elección tomada de la experiencia directa. No teníamos esta clasificación antes de hacer mucha experiencia.

MRG: —Claro. ¿Ud. trabaja aquí, supervisa?

LC: —Superviso solamente. Mi posición en el Ambulatorio de la Universidad, me permite las derivaciones. Yo veo la familia por 1ra. vez y luego la envío al grupo.

MRG: —Es sumamente interesante, ¿La familia no hace una ligazón muy fuerte con Ud. y luego le es difícil el pasaje?

LC: —Hago una entrevista muy, muy breve en la cual yo juego toda mi autoridad.

MRG: —¿Es muy importante para estas familias?

LC: —Sí, es un juego muy hábil. Es una óptima preparación para empezar una terapia familiar con otros.

Advierto a la familia que estas personas están muy ligadas a mí y que si las cosas no van bien ellos estarán conmigo. Es un juego difícil de transmitir.

MRG: —Cuando el paciente designado no se desintoxica en la familia y por algún motivo debe ir a un hospital a desintoxicarse. En estos casos, ¿Uds. operan familiarmente o no?

LC: —No hay imposición. La 1ra. sesión es tratar de ver qué es lo que la familia quiere hacer.

MRG: —Sí, pero supongamos que el paciente está internado...

LC: —En estos casos se prepara a la familia a recibir al paciente en la casa.

MRG: —Ah, entonces se trabaja sin el paciente.

LC: —Es una técnica interesante que se la he visto hacer a Jay Haley, trabajando con la familia en Filadelfia, preparando a la familia para el retorno del paciente.

MRG: —*Porque una de las cosas que aparecen como contradictorias es poner a la familia a cargo de desintoxicar al paciente en la casa. Si uno trabaja con una visión sistémica, uno puede pensar que este paciente con su adicción cumple una función que no cumpliría sin ella y que debiera trabajarse intensamente de algún modo para lograr que esto cambie... sino se torna en una situación contradictoria.*

LC: —Es lo mismo que cuando se trabaja con un niño asmático y su familia desde el punto de vista estructural, su conducta no controlable, o de una anorexia, pero se puede obtener la colaboración de los padres. Hay un pasaje importante de decisión de hacer comprender que será el terapeuta quién se ocupe de la familia y que no es necesario que el niño se ocupe de hacer síntomas.

MRG: —*Quiere decir que se hace el pasaje de la centralidad del paciente por la centralidad del terapeuta.*

LC: —Exacto. Como en algunas familias de psicósomáticos.

MRG: —*De todos modos, parece distinto el tipo de complejidad de las familias de los psicósomáticos y de los adictos.*

LC: —Se parecen a las del drogadicto.

MRG: —*¿A Ud. le parece importante también como a Corelli¹ que no paguen*

los drogadictos, que no aporten para su terapia?

LC: —Son situaciones un poco exteriores, ellos trabajan de otra forma, además trabajan con muchas personas no profesionales. ¿Esto que implica? Una mayor rigidez de las reglas porque si una persona hace terapia por 1ra. vez debe saber exactamente qué debe preguntar a la familia. Yo creo que los terapeutas son más profesionales y entonces hay más posibilidad de hacer otro tipo de trabajo.

MRG: —*Ellos no hacen terapia familiar...*

LC: —Yo pienso que cuando se habla con los padres y se les dice lo que tienen que hacer, se hace un trabajo con la familia. Ellos hacen eso de manera muy rígida.

MRG: —*Claro, hacen un trabajo con la familia, tal vez diferente de una terapia familiar.*

LC: —Depende, cuando ellos sugieren a los padres que no dejen entrar a su hijo, que le cierren las puertas de la casa, eso es una intervención muy fuerte. Se puede llamar a esto terapia familiar o no, también que no le den dinero al paciente.

MRG: —*Cuando yo me refería al dinero, yo no me refería al dinero del paciente, sino al pago de la terapia. Aceptan donaciones económicas, pero no pagos. Le pregunto porque nosotros cobramos a nuestros pacientes drogadictos.*

LC: —En nuestro servicio, por sus características los pacientes no pagan.

MRG: —*Pero, ¿a Ud. le parece importante para la terapia o es irrelevante? ¿No hace de esto un punto especial?*

LC: —No me parece particularmente importante.

MRG: —*¿Quiere agregar algo más?*

LC: —Cuando uno trabaja en un lugar donde se hace terapia familiar con drogadictos; y las familias son muchas y el trabajo va adelante por años, uno debe tener en claro que los drogadictos y las familias de los drogadictos no representan una categoría de patología, a pesar que tienen una apariencia de similitud, hay diferencias entre ellos más importantes que sus similitudes. Esto es muy importante para la terapia, el dato más relevante no es que la hija o el hijo tome drogas, sino las características de la relación interaccional que se plantea. Ahora, hay un marco de referencia: familias de drogadictos, pero no se lo puede considerar como una categoría uniforme.

MRG: —*¿Y Ud. piensa que en otro tipo de familias, se puede considerar patologías, por ejemplo, asmáticos, delincuentes, etc.?*

LC: —Hay otras donde se puede unificar más, acá hay una necesidad de diferenciar. Un punto importante es que la toxicomanía se puede considerar como una autoterapia del sufrimiento subjetivo.

MRG: —*Un poco destructiva...*

LC: —Destructiva pero eficaz.

MRG: —*¿Eficaz desde qué punto de vista?*

LC: —Eficaz en el sentido de calmar el

sufrimiento como la aspirina calma un dolor.

MRG: —*Más o menos, porque termina destruyéndolo. Por ejemplo con heroína, algunos mueren en el camino...*

LC: —También sin drogas, por ejemplo el suicidio. Hay casos donde la drogadicción protege a las personas del suicidio. Es una cuestión muy compleja.

Hay personas que sufren mucho y toman drogas para buscar ayuda por el sufrimiento. Desde el punto de vista subjetivo, la toxicomanía es esto: autoterapia del sufrimiento.

El problema del terapeuta no es la droga, es lo que determina el sufrimiento y aquí hay diferentes tipos de problemas y diferentes soluciones a los problemas. No puede haber una solución al problema. El terapeuta debe diferenciar los problemas que aquejan al drogadicto. El trabajo del toxicómano requiere más atención que otros casos. La clasificación que hemos construido parte de un enfoque sistémico pero utiliza conceptos psicodinámicos y observaciones del comportamiento, etc.

MRG: —*Quiere comentar algo más, porque veo que lo están esperando.*

LC: —No, muchas gracias.

MRG: —*No, gracias a Ud. por haberme permitido entrevistarle.*

1. Juan Corelli, vicedirector del Proyecto UOMO (hombre) de Roma.

Información Bibliográfica

La siguiente es una selección de artículos de revistas y libros sobre el tema de las adicciones desde un enfoque familiar y que comprende el período 1977-1987.

ANGEL P., CONTURE, F., STERNS-CHUSS-ANGEL, S.: "Le toxicomane et ses grands parents", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, Nº 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 53-58.

ANGEL, P., DEFRANCE, J., STERNS-CHUSS-ANGEL, S.: "Analyse Critique de la littérature sur le Toxicomane et sa famille", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, Nº 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 23-34.

BRUCE, A., DIBB, G.: "Interpersonal perception in addict", *Family Process*, Vol. 16, Nº 1, 1977.

BERGERET, J.: "Le toxicomane et sa psychothérapie", *Cahiers Critiques de*

Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux, Nº 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 15-21.

La psicoterapia del toxicómano para ser efectiva necesita tener en cuenta varios elementos: a) la intensa dependencia afectiva del paciente y la necesidad de su participación responsable y activa en el tratamiento, b) un medio ambiente que no reproduzca dicha dependencia y ofrezca mejores relaciones interpersonales, c) un diálogo entre individuos en el que se acepte el doble status de diferencia e igualdad.

CANCRINI, LUIGI: "Une typologie de la toxicomanie", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratique de Réseaux*, Nº 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 137-155.

Analiza el autor distintos aspectos del abuso de drogas, entre ellos:

- 1) El problema de la difusión (sobre todo en Italia).
- 2) El problema de la crisis de la sociedad industrial.
- 3) El problema de los jóvenes y las clases sociales.

A partir de ello, propone una clasificación:

- 1) Toxicomanías traumáticas en una fase de transición del ciclo vital.
- 2) Toxicomanías substitutivas de "neurosis actuales".
- 3) Toxicomanías que se instalan sobre neurosis estructuradas (el síntoma tiene el valor de un comportamiento autoterapéutico).

- 4) Toxicomanías ligadas a fallas en el proceso evolutivo (período del espejo).

CANCRINI, LUIGI, BARBORIE, C.: "Sculptura della famiglia e contrapara-

dossa in un caso grave di tossicomania, *Terapia Familiare*, No 18, 1985, pág. 25-37.

Después de escribir cuatro tipos de situaciones interpersonales que pueden individualizarse en el comportamiento tóxico, los autores analizan un caso de tóxicomanía transaccional en el que el equipo terapéutico (terapeuta y supervisor) utiliza la escultura como intervención paradójica (registro simbólico) en una familia cuya organización comunicacional ha bloqueado la posibilidad de movimiento.

COLEMAN, S., DAVIS, D.: "Family therapy and Drug Abuse. A National Survey", *Family Process*, Vol. 17, No 1, 1978.

COLEMAN, S., KAPLAN, D., DOWNING, R.: "Ciclo vital y pérdida. El vacío espiritual de la adicción a la heroína", *Family Process*, Vol. 25, No 1, 1986, pág. 5-23.

El trabajo postula la función de la adicción a la heroína como resultado de un aprendizaje familiar para soportar la muerte, separación y pérdida a lo largo del ciclo vital. (Publicado en este volumen).

CRETE, R., COLLE, Y.: "Toxicomanie on codicille?", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, No 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 47-52.

DAVIS, D., KLAGSBRUM, M.: "Drug abuse and the Family", *Family Process*, Vol. 16, No 2, 1977.

DEFRANCE, J.: "La trajectoire sociale des familles de toxicomanes", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de*

Pratiques de Réseaux, No 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 79-86.

DUNCAN STANTON, M.: "Le drogue en tant que sauveur: Heroine, mort de la famille", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, No 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 101-108.

La tasa elevada de mortalidad por droga, es considerado como un fenómeno suicida que incluye al drogadicto y a su familia, desde un lugar de sacrificio, en el que el mártir se inmola para "bien" de todos.

DUNCAN STANTON, M., TODD, T.: "La drogadicción y la familia", en Andolfi M., Zwerling, E., *Dimensiones de la terapia familiar*, Editorial Paidós, Bs.As., 1985, cap. 4.

Stanton y Todd analizan diversos aspectos de la familia del drogadicto (de origen y nuclear), de los síntomas y del tratamiento (dificultades y facilidades), para terminar con una propuesta a nivel preventivo a partir de la terapia familiar y la educación.

DUNCAN STANTON, M.: "Famiglia e tossicomania", *Terapia Familiare*, No 6, 1979, pág. 99-115.

Stanton propone el trabajo familiar como el más coherente y eficaz, ya que el síntoma funciona como regulador de las transacciones familiares.

La triangulación, la interdependencia de la pareja conyugal y el PI con una o ambas familias de origen, son algunos de los temas enfatizados.

DUNCAN STANTON, M.: "Family Treatment approaches to Drug Abuse Problems: a review", *Family Process*, Vol. 18, No 3, 1979.

DUNCAN STANTON, M.: "The addict as savior: Heorine Death and Family", *Family Process*, Vol. 16, No 2, 1977.

DUNCAN STANTON, M., TODD, T.: *The family therapy of drug abuse and addiction*, Guilford Press, New York, 1982. En castellano, Ed. Gedisa.

DIAZ USANDIVARAS, C.M.: "Abordaje familiar en el tratamiento de la drogadicción juvenil", *Terapia Familiar*, No 13-14, ACE, Bs. As., pág. 67-87.

Después de describir antecedentes de trabajo familiar con drogadictos, el autor presente su "modelo clínico-estratégico", basado en cinco vectores: 1) interacción familiar, 2) estructura familiar, 3) construcción de la realidad, 4) ciclo de vida familiar, 5) autoestima - confirmación de los otros, que conducen a un proceso terapéutico con objetivos y estrategias específicas.

FRIEDMAN, A., UTADA, A., MOWISEY, M.: "Families of Adolescent Drug Abusers are 'Rigid': are these families either 'disengaged' or 'unrushed', or both?", *Family Process*, Vol. 26, No 1, 1987, pág. 131-148.

La aplicación del "Faces" (cuestionario) basado en el Modelo Circunflejo de Olson a 96 familias con drogadictos en tratamiento, dio resultados inesperados. La mayoría de las familias se categorizaron como "desligadas" y "rígidas". Los autores suponen que el estar en tratamiento las hace más disfuncionales a la vez que aparecen como más "ligadas" que aquellas que no participan en una terapia familiar.

GEBEROWICZ, B., STERNSSCHUSS-ANGEL, S., ANGEL, P.: "Les thérapies

familiales des toxicomanies: les techniques et leurs specificités", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, No 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 59-68.

El objetivo de la T.F. es poner en acción los recursos creativos de la familia y producir el desligamiento de los miembros que en su interacción conducen a circuitos reiterativos que producen la cronicidad.

GLASSERMAN, M.R.: "Drogadicción y familia", *Sistemas Familiares*, Año 2, No 2, 1986, pág. 25-36.

La autora, recordando el sistema familiar, muestra un caso clínico y reflexiona acerca de: 1) tipo de familias con drogadictos, 2) lugar y accionar del terapeuta, 3) contexto de la droga.

HALEY, J.: "Le processus thérapeutique: un probleme d' heroine", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, No 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 121-135.

HUBERTY, D., HUBERTY, C.: "Drug Abuse", en *Helping Families with special problems*, Edit. M. Textor, Jason Aronson Press, New York, 1983, cap. 5.

KORNBLIT, A.: "Categorías semánticas aplicadas a un caso de drogadicción", *Terapia Familiar*, No 6, ACE, Bs. As., 1980, pág. 9-22.

La autora utiliza categorías lingüísticas, en este caso un eje prescriptivo, con 2 modalidades, veredictiva y factitiva para analizar los mensajes de un sistema familiar con un drogadicto.

KAUFMAN, E., KAUFMANN, P.: "La thérapie familiale multiple utilisée avec

des toxicomanes", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, N° 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 109-119.

KAUFMAN, E., KAUFMANN, P. (Edts.): *Family Therapy of Drug and Alcohol Abuse*, Gardner Press, New York, 1979.

Los autores han recopilado una serie de valiosos trabajos, esencialmente clínicos sobre el tema de abuso de droga y alcohol. Este es enfocado desde una perspectiva familiar en el cual el abuso de droga o alcohol conforma un modelo relacional específico que debe ser modificado no sólo en la familia nuclear, sino en la extensa, así como también en los contextos sociales en los que se inscribe el síntoma.

KLAGSBRUM, M., DAVIS, D.: "Substance abuse and Family interaction", *Family Process*, Vol. 16, N° 2, 1977.

KUPETZ, K. y otros: "The Family and Drug abuse Symposium", *Family Process*, Vol. 16, N° 2, 1977.

MADANNES, C., DUKES, J., HARBIN, H.: "Liens Familiaux des Heroinomanes", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, N° 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 87-100.

Las alianzas intergeneracionales alteran la organización jerárquica de la familia, perpetuando los comportamientos adictivos. Esta hipótesis es corroborada en un estudio comparativo con familias de esquizofrénicos y de sujetos normales.

NEUBURGER, M.: "Le problème c'est l'enoncé du problème. Redéfinition recadrage", *Cahiers Critiques de Théra-*

pie Familiale et de Pratiques de Réseaux, N° 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 69-77.

Este trabajo propone a partir de la redefinición del problema y el reencuadre del mismo, re-introducir la paradoja en el cuadro familiar que ayude a la familia a aceptar un modo de funcionamiento en el que coexiste la homeostasis y el cambio, la individuación y la cohesión familiar, la vida y la muerte.

PARODI, A.: "Tossicomania e comunità terapeutica in una ottica sistemica", *Terapia Familiare*, N° 23, marzo, 1987.

STERNSSCHUSS-ANGEL, S., ANGEL, P., GEBEROWICZ, B.: "Le toxicomane, son product et sa famille", *Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*, N° 6, Editions Universitaires, Paris, 1982, pág. 35-45.

STEINGLASS, P., y otros: "Observations of Coinjointly Hospitalized Alcoholic Couples during Sobriety and Intoxication", *Family Process*, Vol. 16, N° 1, 1977.

STRELINCK, R.: "Previniendo hábitos de drogas mediante el cambio de los hábitos médicos: obstáculos y oportunidades", *Family Systems Medicine*, Vol. 4, N° 1, 1986.

Se describe, a partir del lugar del médico de asistencia primaria, el abanico de signos de advertencia familiar para identificar individuos bajo riesgo de abuso de drogas; así como modos de intervención preventiva tanto con los pacientes como con la práctica médica.

WERMUTH, L., SCHEIDT, S.: "Enlisting Family support in Drug Treatment",

Family Process, Vol. 25, N° 1, 1986, pág. 25-33.

Se describen principios y técnicas específicas para conseguir involucrar a la familia del drogadicto en un tratamiento.

El acercamiento psicoeducacional muestra como promisorio el tratamiento foca-

lizado sobre el paciente, como un medio de acceso a un tratamiento familiar más amplio.

Lic. Olga B. MARTINEZ de SARQUIS
Coordinadora de la Sección Bibliografía de CEFYP.

**Instituciones que
atienden gratuitamente
problemas de
drogadicción**

CE.NA.RE.SO.
Combate de los Pozos 2133.
Capital Federal
Tel.: 23-6248 y 27-7182

HOSPITAL DE AGUDOS
"Dr. JUAN A. FERNANDEZ"
(MCBA)
Cerviño 3356. Capital Federal
Tel.: 801-2233/0932

HOSPITAL DE AGUDOS
"Dr. TORCUATO DE ALVEAR"
(MCBA)
Warnes 2630. Capital Federal
Tel.: 51-8985

FAT (Fundación Ayuda
Toxicológica). (Arancel reducido).
Pringles 951. Capital Federal
Tel.: 86-4983

FUNDACION
"VIAJE DE VUELTA"
Calle Ituzaingó 1053. San Fernando
Tel.: 744-0226
Cazadores 482. Haedo
Tel.: 629-1083

CENTRO DE PREVENCIÓN
SOCIAL
Arenales 1318. Vicente López
Tel.: 795-3501

PROGRAMA ANDRES
(Arancel reducido)
-Av. Córdoba 4042. Capital Federal
Tel.: 86-8723

COLONIA ESPERANZA
Balcarce. Pcia. de Buenos Aires

HOSPITAL PIÑERO (MCBA)
Servicio de Psicopatología

COMISION NACIONAL PARA EL
CONTROL DEL NARCOTRAFICO
Y EL ABUSO DE DROGAS
25 de Mayo 459, 6º Piso, Capital Federal
Tel.: 312-1474 y 311-3294

FUNDACION CONVIVIR
Lavalle 381, 3er. Piso, Capital Federal
Tel.: 393-4513

Provincia de Buenos Aires.
COMISION PROVINCIAL DE
TOXICOMANIAS Y NARCOTICOS
Calle 51 N° 1120. La Plata
Tel.: (021) 51-3725

Provincia de Córdoba.
COMISION PROVINCIAL PARA EL
CONTROL DEL NARCOTRAFICO Y
EL USO INDEBIDO DE DROGAS
Chacabuco 1300. Córdoba
Tel.: (051) 66615 y 63627

Provincia de Corrientes.
COMISION PROVINCIAL PARA EL
CONTROL DEL NARCOTRAFICO Y
LA PREVENCION DEL USO
INDEBIDO DE DROGAS
25 de Mayo 1290. Corrientes
Tel.: (0752) 23893

Provincia de Chubut.
COMISION PROVINCIAL DE
TOXICOMANIAS Y NARCOTICOS
Moreno 555. Rawson
Tel.: (0965) 81066 y 81012

Provincia de Entre Ríos.
COMISION PROVINCIAL PARA LA
PREVENCION Y REHABILITACION
DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y EL
CONTROL DEL NARCOTRAFICO
Laprida y Córdoba. Paraná
Tel.: (043) 221560

Provincia de Mendoza.
COORDINACION TEMATICA DE
PREVENCION DEL USO INDEBIDO
DE DROGAS
Centro Cívico. Mendoza
Tel.: (061) 249000

Provincia de Misiones.
COMISION PROVINCIAL PARA EL
CONTROL DEL NARCOTRAFICO Y
EL ABUSO DE DROGAS
Colón 128. Posadas
Tel.: (0752) 39795 y 39825

Provincia de Neuquén.
COMISION PROVINCIAL DE
TOXICOMANIAS Y NARCOTICOS
Roca 393. Neuquén
Tel.: (0943) 23684

Provincia de Río Negro.
COMISION PROVINCIAL PARA EL
CONTROL DEL NARCOTRAFICO Y
EL USO INDEBIDO DE DROGAS
Laprida 240. Viedma
Tel.: (0920) 23958, 22404 y 23006

Provincia de San Juan.
COMISION PROVINCIAL PARA EL
CONTROL DEL USO INDEBIDO DE
DROGAS Y EL NARCOTRAFICO
Rivadavia 27 Oeste, 4to. Piso, San Juan
Tel.: (064) 223157

Provincia de Santa Cruz.
COMISION PROVINCIAL DE
TOXICOMANIAS Y NARCOTICOS
Salta 75. Río Gallegos
Tel.: (0966) 8494

Provincia de Santa Fe.
COMITE PROVINCIAL
INTERMINISTERIAL DE LUCHA
CONTRA LA DROGADICCION Y
EL NARCOTRAFICO
Juan de Garay 2880. Santa Fe
Tel.: (042) 32085, 30512, 22088 y 67578

Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
COMISION TERRITORIAL DE
TOXICOMANIAS Y NARCOTICOS
Deloqui y Lasserre. Ushuaia
Tel.: (0964) 91416 y 91815

Próximos números

1988

VIOLENCIA EN FAMILIA

Editores invitados:
Dra. Ana Giller

1989

TERAPIAS BREVES

Editores invitados:
Lic. Celia Elzufán
Lic. Hugo Hirsch

TERAPIAS DE PAREJA

Editor invitado:
Psic. Alberto González

FAMILIA SANA Y PREVENCION

Editora Invitada:
Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Los autores interesados en algunos de estos temas
pueden enviar sus artículos a la Secretaría de la
Revista según las "Instrucciones para los autores"
que se encuentra en la página siguiente.

FE DE ERRATAS:

En el Nro. 17 donde dice:
Editores invitados debe decir:
Lic. Estrella Joselevich y
Dr. Adolfo Loketek

Instrucciones para los autores

La Revista TERAPIA FAMILIAR publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

ARTICULOS

—Los originales, por triplicado, deberán ser enviados al Director de la Revista, Dr. Alfredo Canevaro, Echeverría 1945, PB, 1428 Capital Federal, República Argentina.

—La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

—No se pagan honorarios por los trabajos aceptados.

—El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o someterlos a corrección de estilo.

—Los trabajos se deben presentar con un original y dos copias escritas a máquina y a doble espacio e incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su

envío a revistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañen el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

—Incluir nombre completo de (los) autor (es), título profesional, dirección e institución a la que pertenece.

—Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a las normas internacionales: 1) Ordenadas alfabéticamente y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2) Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3) Título completo del trabajo citado. 4) Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volumen o Volúmenes; referencia de primera y última página (en este orden), ciudad, editorial, año de publicación.

Ejemplos:

ASHBY, W.R. Introducción a la Cibernética (1956), Bs. Aires, Ed. Paidós, 1972.

o

RUDRAUF, J., Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica. TERAPIA FAMILIAR, 1980, Vol. IV, No 7/8, págs. 87-98, Buenos Aires, Argentina.

—Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.

—Los artículos deberán ser inéditos en lengua española.

Ficha de suscripción

Nros. 19 y 20

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Ediciones A.C.E., No a la Orden.

DIRECCION: C.C. Nro. 94 - Sucursal 28 - Buenos Aires - Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION Nros. 19 y 20

ARGENTINA: Solicitar precio por carta.

EXTERIOR: U\$S 30.—

GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

SECRETARIA E INFORMES
DE LA REVISTA
TERAPIA FAMILIAR:
C.C. 94, Suc. 28, (1428) Bs. As.,
Argentina.